Διοργάνωση:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΩΝ & ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΘΕΡΑΠΕΙΩΝ

Σε συνεργασία με την

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Γ.Ν.Α. «Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΗΜΕΡΙΔΑ

Σύγχρονοι Ουρολογικοί Προβληματισμοί

17 Σεπτεμβρίου 2022



Ξενοδοχείο **Crowne Plaza** ΑΘΗΝΑ

Θα χορηγηθούν 08 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD)

Επιστημονικό **ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ**

ERLEADA®
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ
ΜΕ mHSPC*

Erleada®
(apalutamide) tablets

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΟΝ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ mHSPC[1,2*]

65,1% ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΗΤΑΝ ΕΝ ΖΩΗ ΕΠΕΙΤΑ ΑΠΟ 4 ΕΤΗ[2*]





Μάθετε περισσότερα στο Janssen Medical Cloud

ADT=θεραπεία στέρησης ανδρογόνων, mHSPC=μεταστατικός ορμονοευαίσθητος καρκίνος του προστάτη, OS=συνολική επιβίωση.
*Διάμεση OS δεν επετεύχθη στο σκέλος του ERLEADA® έναντι 52,2 μηνών (41,9 to NR) στο σκέλος εικονικού φαρμάκου + ADT (HR=0,65, 95% CI: 0,53-0,79, p<0,0001).[2]

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Βιβλιογραφία:
1. ERLEADA® Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
2. Chi KN, et al. J Clin Oncol 2021;39:2294–2303.

Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος βρίσκεται σε επόμενη σελίδα.

JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.Β.Ε.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Janssen Oncology
PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson&Johnson

CP-309088_ERL_0422_001

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή, η Ουρολογική Κλινική του ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς» σας καλωσορίζει, όπως κάθε χρόνο, στην Ημερίδα που διοργανώνει στις 17 Σεπτεμβρίου 2022 στο ξενοδοχείο Crowne Plaza, με θέμα «Σύγχρονοι Ουρολογικοί προβληματισμοί».

Ευελπιστούμε να συζητήσουμε ένα σημαντικό όγκο των πολύ ενδιαφερόντων θεμάτων της Ειδικότητάς μας και να ανταλλάξουμε απόψεις και προβληματισμούς σε τομείς που εξελίσσονται και μεταβάλλονται συνεχώς. Με στόχο τη συμβολή της στην κάλυψη αυτής της ανάγκης, η Οργανωτική Επιτροπή κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάρτιση ενός άρτιου κι ολοκληρωμένου προγράμματος. Φέτος, ωστόσο, είμαστε υπερήφανοι και για έναν ακόμα λόγο: Γιατί θα δώσουμε «βήμα» και «λόγο» σε νέους Συναδέλφους. Η θεματολογία θα παρουσιαστεί από Ειδικευόμενους και νέους Ειδικευμένους Ουρολόγους, Ακτινοθεραπευτές και Ογκολόγους, υπό την επιστημονική καθοδήγηση και συνεργασία των εμπειρότερων και αναγνωρισμένων Δασκάλων τους, η παρουσία των οποίων θα είναι, επίσης, ενεργός. Θεωρούμε ότι αυτή η καινοτομία θα καταστήσει την Ημερίδα μας πιο διαδραστική κι ελκυστική.

Με τη βεβαιότητα ότι η συμμετοχή σας θα συμβάλει στην επίτευξη του γόνιμου επιστημονικού διαλόγου, σας προσκαλούμε και σας περιμένουμε στην εκδήλωσή μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Δρ. Κωνσταντίνος Ντούμας
Συντονιστής Διευθυντής
Ουρολογικής Κλινικής
Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

Cysticlean®

240 mg PAC

Για την Υγεία του Ουροποιητικού Συστήματος

240 mg PAC



STILVI PHARMACEUTICALS S.A.
Λ. Ποσειδώνος 18, Καλλιθέα - 17674 Αθήνα
T 210 9902924 / **F** 210 9902743
email: info@stilvipharma.gr
www.stilvipharma.gr

Τα Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου. Συμβουλευτείτε τον γιατρό σας αν είστε έγκυος, θηλάζετε, βρίσκεστε υπό φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζετε προβλήματα υγείας. Να μην γίνετε υπέρβαση της συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Να φυλάσσεται σε μέρος και σε θέση την οποία δεν βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 7793777. Αρ Γνωστοποίησης ΕΟΦ 58142/04.09.2015

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρίστας Οδυσσέας
Γλύκας Ιωάννης
Λάμπρου Σταύρος
Ντούμας Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Σταθούρος Γεώργιος
Φραγκούλης Αριστόδημος
Φραγκούλης Χαράλαμπος

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αρίστας Οδυσσέας
Βαρκαράκης Ιωάννης
Μανούσακας Θεόδωρος
Μπάμιας Αριστοτέλης
Νικολόπουλος Παναγιώτης
Ντούμας Κωνσταντίνος
Παπαδόπουλος Γεώργιος
Παπατσώρης Αθανάσιος
Σκολαρίκος Ανδρέας
Σταθούρος Γεώργιος
Στραβοδήμος Κωνσταντίνος
Φραγκούλης Αριστόδημος
Φραγκούλης Χαράλαμπος
Χρυσοφός Μιχαήλ

Με το Arvekap®
μπορείς να αλλάξεις θέμα συζήτησης

Arvekap® 22.5mg
triptorelin



Έχεις τον **ΕΛΕΓΧΟ** του καρκίνου του προστάτη

ΜΙΛΗΣΕ για όσα έχουν αξία για τον άνδρα

Arvekap®: Προσφέρει τη δυνατότητα υποστήριξης και άλλων αναγκών του άνδρα.*

Οι περιεκτικότητες 1, 3 και 6 μηνών του Arvekap® ήταν καλά ανεκτές[1-7] και μείωσαν σημαντικά τα συμπτώματα από το Κατώτερο Ουροποιητικό Σύστημα (LUTS) σε διάστημα 48 εβδομάδων.[8]

Η 6μηνη μορφή του Arvekap®, ανταποκρίνεται στη συχνότητα των ενέσεων που προτιμούν οι άνδρες με καρκίνο του προστάτη.[9]

*Η μείωση του αριθμού των ενέσεων λόγω της τιτλοποίησης στην 6μηνη μορφή του Arvekap από σκεύασμα αγωνιστή LHRH μηνιαίας ή 3μηνιαίας διάρκειας, οδήγησε σε εξοικονόμηση χρόνου αντίστοιχου με 35,1 λεπτά ανά ασθενή (n=41).[3]

1. Heyns C, Simonin M, Grosgurin P, et al. BJU Int. 2003;92(3):226–231. **2.** Teillac P, Heyns C, Kaisary A, et al. Horm Res. 2004;62(5):252–258. **3.** Lundström EA, Rencken RK, van Wyk JH, et al. Clin Drug Investig. 2009;29(12):757–765. **4.** Arvekap® 22.5 mg. Summary of product characteristics, IPSEN MON. ΕΠΕ. **5.** Arvekap® 3.75 mg Summary of product characteristics, IPSEN MON. ΕΠΕ. **6.** Arvekap® 11.25 mg Summary of product characteristics, IPSEN MON. ΕΠΕ. **7.** Merseburger AS, Hupe MC. Adv Ther. 2016;33(7):1072–1093. **8.** Gil T, Aoun F, Cabri P, et al. Ther Adv Urol. 2015;7(3):116–124. **9.** Schulman C. BJU Int. 2007;100(Suppl. 1):6–11.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος που βρίσκεται σε επόμενες σελίδες.
Τ.Π.: 425,32€ • Λ.Τ: 498,77€ • Δ.Τ.Φ.: 23/12/2021

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

IPSEN MON.ΕΠΕ
Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ
Τηλέφωνο: 210 98 43 324, 210 98 58 930 & 210 98 58 940
Φαξ: 210 98 87 911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com
http://www.ipsen.gr

IPSEN Innovation for patient care

10 ARV 11,25/3,75/22,5-B/ΙΟΥΛ 2022.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Σάββατο, 17 Σεπτεμβρίου 2022

08:30-09:00 Προσέλευση - Εγγραφές

09:00-10:00 Καρκίνος ουροδόχου κύστης

Προεδρείο: **Στραβοδήμος Κ.**

09:00-09:15	Κυστεκτομή σε μη-μυοδιηθητική νόσο: Κριτήρια επιλογής (Bravo Trial).	**Κοριτσιάδης Γ., Μπαρμπούτης Π.**
09:15-09:30	Νεότερες μοριακές και απεικονιστικές μέθοδοι στη διάγνωση του καρκίνου της κύστης.	**Αρίστας Ο., Σταματάκος Π.**
09:30-09:45	Επιλογές εκτροπής και ποιότητα ζωής σε κυστεκτομή. Real world data.	**Φραγκούλης Χ., Λεβέντη Α.**
09:45-10:00	Ο ρόλος της κυστεκτομής σε ολιγομεταστατική νόσο.	**Γαλανάκης Ι., Λάμπρου Σ.**

10:00-11:00 Καρκίνος νεφρού

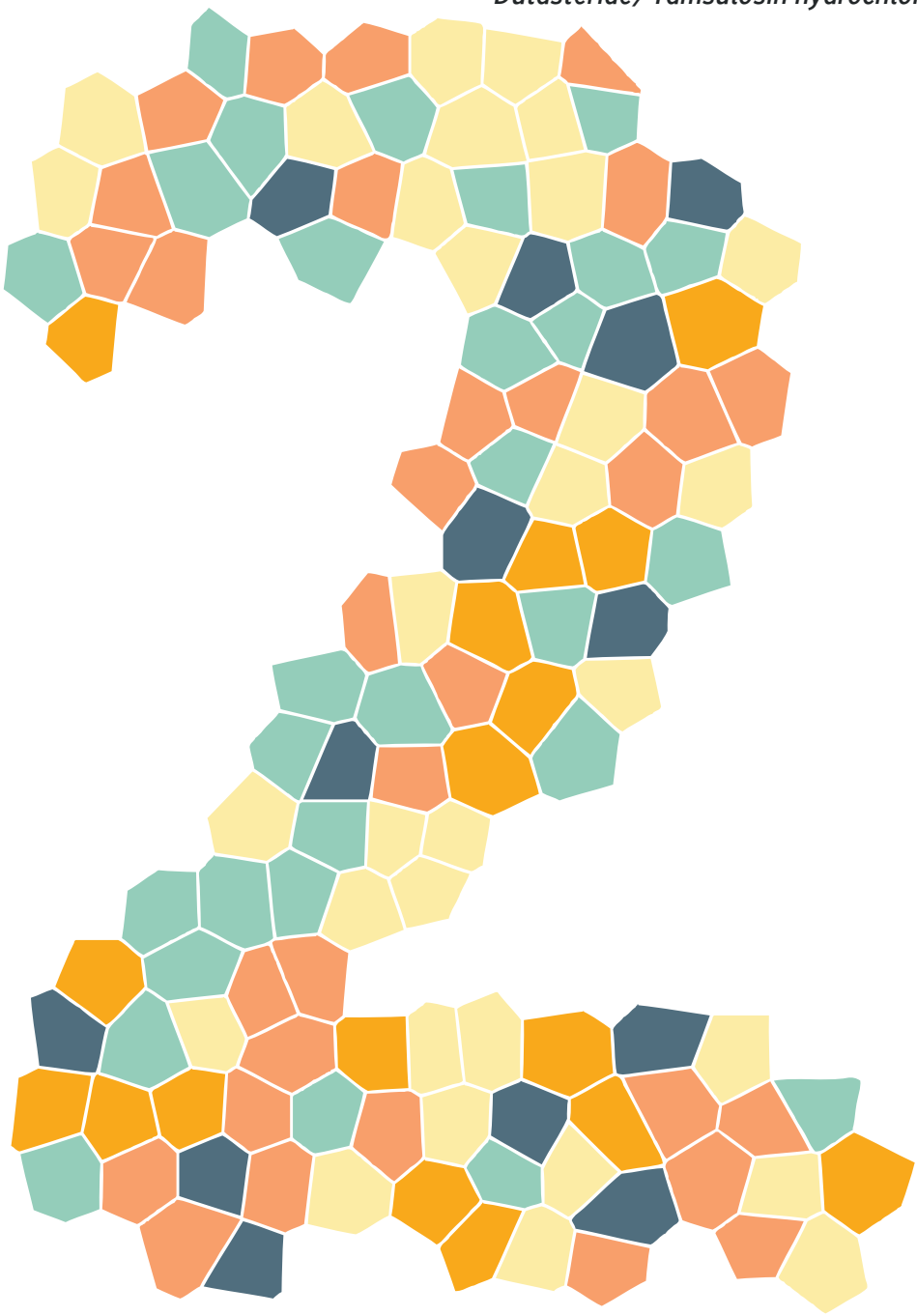
Προεδρείο: **Ντούμας Κ., Σαμέλης Γ.**

10:00-10:15	Ο ρόλος της Ακτινοθεραπείας στον μεταστατικό καρκίνο του νεφρού: Είναι, ακόμα, πειραματικός;	**Ζυγογιάννη Α., Γρενζελιά Μ.**
10:15-10:30	Τεχνικές διατήρησης του νεφρικού παρεγχύματος στον καρκίνο του νεφρού.	**Φεράκης Ν., Γάσπαρος Φ.**
10:30-10:45	Έχει ρόλο η επικουρική θεραπεία στον τοπικά προχωρημένο καρκίνο του νεφρού;	**Κωστούρος Ε.**
10:45-11:00	Ο ρόλος της κυτταρομειωτικής νεφρεκτομής στη μεταστατική νόσο ενδιαμέσου κινδύνου. Έχει αλλάξει τα δεδομένα η Ανοσοθεραπεία;	**Μανούσακας Θ., Ζαμπαύτης Χ.**

11:00-11:30 **Διάλειμμα / Καφές**

DYOSTER®

Dutasteride/Tamsulosin hydrochloride



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε όλες τις ανεπιθύμητες ενέργειες για όλα τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Χορηγείται με ιατρική συνταγή

Λ.Τ. DYOSTER 0,5MG/0,4MG, BTx30: 14,23 €

RAFARM A.E.B.E. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Κορίνθου 12, 15451 Ν. Ψυχικό, Αθήνα
Τηλ.: 211 176 1000 e-mail: info@rafarm.gr www.rafarm.gr

Για συνταγογραφικές πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα της εταιρείας ή συμβουλευθείτε την Π.Χ.Π. σαρώνοντας το **QR code**

ADV/DYO/03/07.2022

11:30-12:30 Καρκίνος προστάτη Ι

Προεδρείο: **Μητρόπουλος Δ.**

11:30-11:45 Ενεργός παρακολούθηση: Η MRI είναι αρκετή. **Νικολόπουλος Π., Μπράττης Ν.**

11:45-12:00 Ενεργός παρακολούθηση: Απαιτείται παρακολούθηση με βιοψία. **Καλογερόπουλος Θ., Καπόγιαννης Φ.**

12:00-12:15 Εισαγωγική θεραπεία σε ασθενείς με high-risk καρκίνο προστάτη: Τι δεδομένα διαθέτουμε. **Παπατσώρης Α., Μανωλίτσης Ι.**

12:15-12:30 Αντιμετώπιση τοπικής/περιοχικής υποτροπής μετά από ριζική θεραπεία (RP, RT) σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη. **Βαρκαράκης Ι., Κυριαζής Ι.**

12:30-13:00 Δορυφορική Διάλεξη **Sponsored by** AMGEN Oncology

Προεδρείο: **Ντούμας Κ.**

Η σημασία της πρόληψης των οστικών συμβαμάτων σε ασθενείς με ευνουχοάντοχο καρκίνο του προστάτη και οστική νόσο **Παπαδόπουλος Γ.**

13:00-13:30 Δορυφορική Διάλεξη **Sponsored by** Bristol Myers Squibb

Προεδρείο: **Ντούμας Κ.**

Η συμβολή της επικουρικής ανοσοθεραπείας στην αντιμετώπιση του μετεγχειρητικού ουροθηλιακού καρκίνου **Παπατσώρης Α.**

13:30-14:00 Καρκίνος προστάτη ΙΙ

Προεδρείο: **Φασουλάκης Χ.**

13:30-13:45 Χαμηλού φορτίου, μεταστατική νόσος (υποτροπή): Συστηματική ή θεραπεία στοχευμένη στις μεταστάσεις; **Σκρεπέτης Κ., Φασουλάκης Κ.**

13:45-14:00 Γονιδιακός έλεγχος στον καρκίνο του προστάτη: πότε πρέπει να γίνεται; **Φραγκιάδης Ε., Δουρούμης Κ.**

14:00-15:00 **Μεσημβρινή Διακοπή / Ελαφρύ γεύμα**

Axion Medical Health

TissuePatch™

Surgical sealant film

TissuePatch™ is a synthetic, self-adhesive surgical sealant and barrier



Fast, Safe & Effective Sealing

It Adheres,
It Seals,
It's Absorbed.

Axion Medical Health

τηλ.: 210 9412775 info@axionhealth.gr www.axionhealth.gr

15:00-16:00 Καρκίνος προστάτη ΙΙΙ

Προεδρείο: **Δεληβελιώτης Χ.**

15:00-15:15 Μη μεταστατικός ευνουχοάντοχος καρκίνος του προστάτη. **Σταθούρος Γ., Καούλλας Α.**

15:15-15:30 Μεταστατικός ορμονοευαίσθητος καρκίνος προστάτη: Αρκεί ο ευνουχισμός; **Χρυσοφός Μ., Αδάμος Κ.**

15:30-15:45 Μεταστατικός ευνουχοάντοχος καρκίνος του προστάτη: 10 χρόνια μετά… **Παπαδημητρίου Β.**

15:45-16:00 Theranostics: Μια νέα εποχή αρχίζει; **Λιόντος Μ.**

16:00-17:00 Το βήμα των Ογκολόγων και Ακτινοθεραπευτών

Προεδρείο: **Μπάμιας Α., Κουλουλίας Β.**

16:00-16:12 Πρωτόκολλα διατήρησης της κύστης σε μυοδιηθητική νόσο. **Κουγιουμτζοπούλου Α.**

16:12-16:24 Η Ανοσοθεραπεία ως Εισαγωγική κι Επικουρική θεραπεία σε ασθενείς μη κατάλληλους για ΧΜΘ, στον καρκίνο της κύστης. **Σακελλάκης Μ.**

16:24-16:36 Νεότερα δεδομένα στη διαχείριση της μεταστατικής νόσου στον καρκίνο της κύστης. **Ζακοπούλου Ρ.**

16:36-16:48 Εισαγωγική vs Επικουρικής θεραπείας σε Ουροθηλιακό καρκίνο Ανώτερου Ουροποιητικού. **Κουτσούκος Κ.**

16:48-17:00 Τεχνικές ακτινοβόλησης του προστάτη. **Τρογκάνης Ν.**

17:00-17:30 **Διάλειμμα / Καφές**

17:30-18:30 Παθήσεις προστάτη/Ανδρολογία

Προεδρείο: **Αλαμανής Χ.**

17:30-17:45 Ο ρόλος της συνδυαστικής φαρμακευτικής αγωγής. Ήρθε το τέλος της μονοθεραπείας; **Μητσογιάννης Η., Πικραμένος Κ.**

17:45-18:00 Χρόνια προστατίτιδα και στυτική δυσλειτουργία: Σχέση αμφίδρομη; **Μακαρούνης Κ.**

18:10-18:15 Διαχείριση στυτικής δυσλειτουργίας σε ασθενή με υπογοναδισμό. **Πρωτογέρου Β., Μελαχροινάκης Φ.**

18:15-18:30 Χρήση των κρουστικών κυμάτων στην Ανδρολογία. **Κουσουρνάς Γ.**


NUBEQA®
(darolutamide) 300 mg tablets
BAYER
Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας:
Bayer AG 51368, Leverkusen, Γερμανία
Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Bayer Ελλάς ΑΒΕΕ, Σωρού 18-20, 151 25 Μαρούσι
Τοπικός αντιπρόσωπος του Κατόχου Άδειας Κυκλοφορίας στην Κύπρο: Novagem Ltd, Τηλ:00357 22483858
Τμήμα Ιατρικής Πληροφόρησης
Τηλ: +30 210 6187742, Φαξ: +30 210 6187522
Email: medinfo.gr.cy@bayer.com
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.
PP-NUB-GR-0006-1

18:30-19:30 Ακράτεια, Τεχνολογία, Παθήσεις πέους

Προεδρείο: **Γκερζελής Ι.**

18:30-18:42	Μικτή ακράτεια στις γυναίκες: Διαγνωστική και θεραπευτική προσπέλαση.	**Φλωράτος Δ.**
18:42-18:54	Δερματολογικές βλάβες πέους: Τι πρέπει να γνωρίζει ο Ουρολόγος.	**Φραγκούλης Α., Μαρή Β.**
18:54-19:06	Χρήση των laser στη χειρουργική της ΚΥΠ.	**Κυριαζής Ι.**
19:06-19:18	Αντιμετώπιση στενωμάτων ουρητήρα: Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική ή όχι;	**Καλληδώνης Π., Πετεινάρης Α.**
19:18-19:30	Αντιμετώπιση λιθίασης την εποχή των εύκαμπτων ουρητηροσκοπίων μιας χρήσεως.	**Δελλής Α., Γλύκας Ι.**

19:30-19:45 Συμπεράσματα

Λήξη Εργασιών Ημερίδας

Tadalafil Ariti
Ταδαλαφίλη 5mg



Tadalafil Ariti
Ταδαλαφίλη 10mg



Tadalafil Ariti
Ταδαλαφίλη 20mg



Solicin® 5 mg
Ηλεκτρική σολιφενασίνη



Solicin® 10 mg
Ηλεκτρική σολιφενασίνη



Lutrak® 50mg
Bicalutamide



Tamsulosin Ariti
0,4 mg Υδροχλωρική Ταμσουλοζίνη







Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ARITI A.E. ΑΘΗΝΑ: Λεωφ. Τατοΐου 52,
13677 Αχαρνές
Τηλ.: 210 8002650 - Fax: 210 6207503
www.ariti.gr - info@ariti.gr

ariti® Δίπλα στον άνθρωπο

ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Αδάμος Κωνσταντίνος	Επικουρικός Επιμελητής, Γ' Ουρολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «ΑΤΤΙΚΟΝ»
Αλαμανής Χρήστος	Χειρουργός Ουρολόγος, Καθηγητής, Ε.Κ.Π.Α.
Αρίστας Οδυσσέας	Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Βαρκαράκης Ιωάννης	PhD, FEBU, ECFMG, Καθηγητής Ουρολογίας, Β' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
Γαλανάκης Ιωάννης	MD, PhD, FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος, Αν. Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Γάσπαρος Φώτιος	Ειδικευόμενος Ουρολόγος, ΓΝΑ Κοργιαλενειο-Μπενάκειο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός
Γκερζελής Ιωάννης	Διευθυντής, Επιστημονικός Υπεύθυνος, Νοσοκομείο Αγία Όλγα
Γλύκας Ιωάννης	Ουρολόγος, Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών
Γρενζελιά Μαρία	Ειδικευόμενη Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Αρεταίειο Νοσοκομείο
Δεληβελιώτης Χαράλαμπος	Καθηγητής Ουρολογίας, Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
Δελλής Αθανάσιος	MD, PhD, FEBU, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας, Β' Χειρουργική Κλινική, Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γενικός Γραμματέας Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας (Ε.Ο.Ε.)
Δουρούμης Κωνσταντίνος	Ειδικευόμενος, Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Ζακοπούλου Ρουμπίνη	Παθολόγος - Ογκολόγος, Γ.Ν. «Αττικόν»
Ζαμπαύτης Χρίστος	Χειρουργός-Ουρολόγος, Κέντρο Προηγμένης Λαπαροσκοπικής και Ενδοσκοπικής Χειρουργικής Ουρολογίας Central Urology, Κλινική Λευκός Σταυρός
Ζυγογιάννη Άννα	Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Π.Γ.Ν. «Αρεταίειο»
Καλληδώνης Παναγιώτης	Επίκουρος Καθηγητής Ενδοσκοπικής και Λαπαροσκοπικής Ουρολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών
Καλογερόπουλος Θεόδωρος	Χειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ, Ουρολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Καούλλας Αντώνιος	Ειδικευόμενος Ουρολογίας, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς
Καπόγιαννης Φίλιππος	Επικουρικός Επιμελητής, Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κοριτσιάδης Γεώργιος	Επιμελητής Α' Ουρολογικής Κλινικής, Ε.Α.Ν.Π. «Μεταξά»

ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Κουγιουμτζοπούλου Ανδρομάχη	MD, MSc, Ακτινοθεραπεύτρια-Ογκολόγος, Μονάδα Ακτινοθεραπείας, Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»
Κουλουλίας Βασίλειος	Καθηγητής Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας, Μονάδα Ακτινοθεραπείας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας
Κουσουρνάς Γεώργιος	Χειρουργός Ουρολόγος-Ανδρολόγος
Κουτσούκος Κωνσταντίνος	"Παθολόγος - Ογκολόγος, MD, MSc, Ακαδημαϊκός Υπότροφος, Θεραπευτική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Συνεργάτης Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου"
Κυριαζής Ιάσων	MD, PhD, MSc, FEBU Χειρουργός Ουρολόγος Λευκός Σταυρός Αθηνών
Κυριαζής Ιωάννης	Ειδικευόμενος Ουρολογίας, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
Κωστούρος Ευθύμιος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιμελητής Α', Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Λάμπρου Σταύρος	Ουρολόγος, Επιμελητής Ουρολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών
Λεβέντη Αγγελική	Ειδικευόμενη Ουρολογίας, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Λιόντος Μιχαήλ	Παθολόγος - Ογκολόγος, Επικουρικός Καθηγητής Θεραπευτικής Ογκολογίας Ε.Κ.Π.Α., Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα»
Μακαρούνης Κωνσταντίνος	MD, FEBU, FECSM, cPhD, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής Θεραπευτηρίου Αθηνών
Μανούσακας Θεόδωρος	Διευθυντής, Γ' Ουρολογική Κλινική, Ερρίκος Ντυνάν Hospital Center
Μανωλίτσης Ιωάννης	Ειδικευόμενος Ουρολόγος, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
Μαρή Βικτωρία	Ειδικευόμενη Ουρολογίας, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Μελαχροινάκης Φάνης	Ουρολόγος
Μητρόπουλος Διονύσιος	Καθηγητής Ουρολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής, Α' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Λαϊκό»
Μητσογιάννης Ηρακλής	MD PhD FEBU, Χειρουργός Ουρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Ε.Κ.Π.Α., Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
Μπάμιας Αριστοτέλης	Παθολόγος-Ογκολόγος, Καθηγητής Θεραπευτικής-Παθολογίας-Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α., Β' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Μπαρμπούτης Πασχάλης	Επικουρικός Επιμελητής, Ουρολογική Κλινική, Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας
Μπράττης Νικόλαος	Χειρουργός Ουρολόγος, Επιμελητής Ουρολογικής Κλινικής 417 ΝΙΜΤΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Νικολόπουλος Παναγιώτης	MD, PhD Χειρουργός Ουρολόγος, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής 401 ΓΣΝΑ, Διδάκτωρ Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α.
Ντούμας Κωνσταντίνος	FEBU, Συντονιστής Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Παπαδημητρίου Βάιος	Χειρουργός Ουρολόγος, Ιδιωτικό Ιατρείο και Ουροδυναμικό Εργαστήριο, Λαμία
Παπαδόπουλος Γεώργιος	Επιμελητής Α' Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Παπατσώρης Αθανάσιος	Καθηγητής Ουρολογίας Ε.Κ.Π.Α., Β' Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
Πετεινάρης Αγγελής	MD, MSC, Ειδικευόμενος Ουρολογίας, Π.Γ.Ν.Π Ρίο
Πικραμένος Κωνσταντίνος	Ειδικευόμενος, Β΄ Πανεπιστημιακή Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο»
Πρωτογέρου Βασίλειος	Χειρουργός Ουρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Ε.Κ.Π.Α., Υπεύθυνος Ανδρολογικού Ιατρού Γ' Ουρολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν. «Αττικόν», Διευθυντής Ε' Ουρολογικής Κλινικής Metropolitan General & Επιστημονικός Διευθυντής Androclinic
Σακελλάκης Μηνάς	MD, MSc, Παθολόγος-Ογκολόγος, Metropolitan Hospital
Σαμέλης Γεώργιος	Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιστημονικά Υπεύθυνος, Διευθυντής, Ογκολογική Μονάδα, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο», Πρόεδρος Ελληνικής και Διεθνούς Εταιρείας Μοριακά Στοχευμένων Εξατομικευμένων Θεραπειών
Σκρεπέτης Κωνσταντίνος	Συντονιστής Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν. Μεσσηνίας
Σταθούρος Γεώργιος	Επιμελητής Α', Ουρολογική Κλινική, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Σταματάκος Παναγιώτης- Βελισσάριος	Ειδικευόμενος Ουρολογίας, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Στραβοδήμος Κωνσταντίνος	Χειρουργός Ουρολόγος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ουρολογίας Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ
Τρογκάνης Νικόλαος	MD, MSc, Ακτινοθεραπευτής Ογκολόγος, Επιμελητής Β', Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας, Π.Γ.Ν. «Αττικόν»
Φασουλάκης Κωνσταντίνος	Ειδικευόμενος Ουρολογίας, Γεν. Νοσ. Μεσσηνίας, Νοσ. Μον. Καλαμάτας
Φασουλάκης Χαράλαμπος	MD, PhD, FEBU, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Φεράκης Νικόλαος	MD, PhD, FEBU, Διευθυντής Ουρολογικής Κλινικής, Κοργιαλένειο Μπενάκειο Νοσοκομείο ΕΕΣ
Φλωράτος Λ. Διαμαντής	MD, FEBU, Δρ. (ΕΚΠΑ), PhD (Katholieke Universiteit Nijmegen, NL), Υπεύθυνος Ιατρείου Νευρο-ουρολογίας και Ουροδυναμικού εργαστηρίου Κ.Α.Α. «ΑΚΤΙΟΣ»

ΠΡΟΕΔΡΟΙ - ΟΜΙΛΗΤΕΣ

Φραγκιάδης Ευάγγελος	Χειρουργός Ουρολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α' Ουρολογικής Κλινικής Ε.Κ.Π.Α.
Φραγκούλης Αριστόδημος	Διευθυντής Ε.Σ.Υ., Ουρολογικό Τμήμα, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Φραγκούλης Χαράλαμπος	MD, MSc, Ουρολογος, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»
Χρυσοφός Μιχαήλ	Καθηγητής Ουρολογίας, Ε.Κ.Π.Α., Διευθυντής Γ' Ουρολογικής Κλινικής Π.Γ.Ν.Α. «Αττικόν»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

↘ Οργάνωση:
Ελληνική και Διεθνής Εταιρεία Μοριακά Στοχευμένων & Εξατομικευμένων Θεραπειών

↘ Σε συνεργασία με
Ουρολογική Κλινική Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς»

↘ Ημερομηνία Διεξαγωγής:
17 Σεπτεμβρίου 2022

↘ Χώρος Διεξαγωγής:
Ξενοδοχείο Crowne Plaza,
Μιχαλακοπούλου 50
Αθήνα 11528
Τηλ.: 210 727800

↘ Εγγραφές:
Η εγγραφή στην Ημερίδα είναι δωρεάν. Η παρακολούθηση επιτρέπεται μόνο σε Επαγγελματίες Υγείας και σε προπτυχιακούς/μεταπτυχιακούς φοιτητές.

↘ Οδηγίες Φυσικής Παρακολούθησης:
Στους συμμετέχοντες θα σταλεί ηλεκτρονικό badge (barcode), το οποίο θα πρέπει να σκανάρουν κατά την είσοδο και έξοδο τους στην αίθουσα.

↘ Οδηγίες Διαδικτυακής Παρακολούθησης:
Εάν είσαστε νέος χρήστης παρακαλούμε ακολουθήστε τη διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία στο www.livemed.gr (πατήστε στο πεδίο **Register/Εγγραφή**).
Η δημιουργία λογαριασμού είναι δωρεάν και υποχρεωτική για την παρακολούθηση των ομιλιών.
Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο Livemed χρησιμοποιήστε τους κωδικούς σας για να συνδεθείτε, επιλέξτε την κατηγορία Live και το συνέδριο που θέλετε να παρακολουθήσετε και στη συνέχεια το εικονίδιο **Go Live ή Go Virtual**.

Στη συνέχεια για να συνδεθείτε με την αίθουσα, επιλέγετε από το μενού που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης σας, την **«Αίθουσα Συνεδριάσεων»**.

Εάν σας ενδιαφέρει να παραλάβετε πιστοποιητικό παρακολούθησης, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε την εγγραφή σας στο Σεμινάριο μέσω της Εικονικής Γραμματείας, πατώντας το αντίστοιχο εικονίδιο **«Εγγραφή»**, ώστε να αρχίσει να καταγράφεται ο χρόνος.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

↘ Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης:

Σύμφωνα με τα κριτήρια της EACCME-UEMS θα χορηγηθούν 08 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits).

↘ Παραλαβή πιστοποιητικού:

Το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί μετά το πέρας των εργασιών της Ημερίδας σε όσους σύνεδρους έχουν κάνει εγγραφή. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή του πιστοποιητικού παρακολούθησης είναι η συμπλήρωση τουλάχιστον του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος και η ηλεκτρονική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αξιολόγησης της Ημερίδας.
Ο αριθμός Μορίων Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD), θα υπολογιστεί βάσει του χρόνου παρακολούθησης που θα καταγραφεί στην πλατφόρμα Livemed για όσους έχουν διαδικτυακή παρουσία και στο σύστημα καταμέτρησης στην είσοδο της αίθουσας για όσους έχουν φυσική παρουσία.

↘ Γραμματεία:

ets Events & Travel Solutions

E.T.S. Events & Travel Solutions A.E.
Ελ. Βενιζέλου 154, 171 22 Ν. Σμύρνη
Τηλ.: 210-98 80 032 Φαξ: 210-98 81 303
E-mail: ets@otenet.gr, ets@events.gr
Website: **www.events.gr**

Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, εκτέλεση, λήψη (download), μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας, του συνόλου ή μέρους του περιεχομένου του Προγράμματος. Η E.T.S. Events & Travel Solutions επιφυλάσσεται ρητώς παντός νομίμου δικαιώματός της για τη διαφύλαξη των δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Για αναλυτικότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το το www.events.gr (πολιτική απορρήτου)

ΧΟΡΗΓΟΙ

AMGEN Oncology
ariti Στήλη ίσον άνδρας
astellas
Axion Health
Bayer
Bristol Myers Squibb
DEMO ABEE ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Έλιξ ενδοσκοπικές εφαρμογές
FARAN ONCOLOGY
FarmaSyn SA PHARMACEUTICALS
ιατρική τομή EuroTec
INNOVIS Future health today
IPSEN ONCOLOGY
janssen Oncology PHARMACEUTICAL COMPANIES OF Johnson & Johnson
Lavipharm
MEDICARE HELLAS S.A.
medprisma
RAFARM
RECORDATI
SOFMEDICA
stilvi για την υγεία
BIANEΞ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Vocate Φαρμακευτική α.ε.
WinMedica Serving Health for Life

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Arvekap 22,5 mg κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης απελέασεως. **2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε φιαλίδιο περιέχει triptorelin embonate που αντιστοιχεί σε 22,5 mg τριπτορελίνης. Μετά την αναδιάταση με 2 ml. διαλύτη, 1 ml αναδιαταθέντος εναιωρήματος περιέχει 11,25 mg τριπτορελίνης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. **3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα παρατεταμένης απολέσεως. Κόνις: Λευκή έως ελαφρώς κίτρινη σκόνη. Διαλύτης: Διαυγές διάλυμα. **4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις:** Το Arvekap 22,5 mg ενδείκνυται για τη θεραπεία του τοπικά προχωρημένου ή μεταστατικού ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου του προστάτη. Το Arvekap 22,5 mg ενδείκνυται για τη θεραπεία του υψηλού κινδύνου εντοπισμένου ή τοπικά προχωρημένου, ορμονοεξαρτώμενου καρκίνου του προστάτη σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία. Βλ. παράγραφο 5.1. Το Arvekap 22,5 mg ενδείκνυται για τη θεραπεία της κεντρικής πρώιμης ήβης (CPP) σε παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω, με εμφάνιση της κεντρικής πρώιμης ήβης πριν από την ηλικία των 8 ετών στα κορίτσια και των 10 ετών στα αγόρια. **4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:** Δοσολογία: Η συνιστώμενη δόση του Arvekap 22,5 mg είναι 22,5 mg τριπτορελίνη (1 φιαλίδιο) χορηγούμενο κάθε έξι μήνες (εικοσιτέσσερις εβδομάδες) ως μία εφάπαξ ενδομυϊκή ένεση. Ως συγχορηγούμενο και ακόλουθο της ακτινοθεραπείας στον υψηλού κινδύνου εντοπισμένο ή τοπικά προχωρημένο ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του προστάτη, κλινικά δεδομένα έχουν δείξει ότι η ακτινοθεραπεία, ακολουθούμενη από μακροχρόνια θεραπεία στέρησης ανδρογόνων είναι προτιμότερη από ακτινοθεραπεία ακολουθούμενη από βραχυχρόνια θεραπεία στέρησης των ανδρογόνων. Βλέπε παράγραφο 5.1. Η διάρκεια της θεραπείας στέρησης ανδρογόνων, η οποία συνιστάται από ιατρικές κατευθυντήριες οδηγίες για ασθενείς με υψηλού κινδύνου εντοπισμένο ή τοπικά προχωρημένο καρκίνο του προστάτη που λαμβάνουν ακτινοθεραπεία είναι 2-3 χρόνια.Σε ασθενείς με ανθεκτικό στον ευνουχισμό, μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, μη χειρουργικά ευνουχισμένους, οι οποίοι λαμβάνουν κάποιον ογωνιστή GnRH, όπως η τριπτορελίνη και είναι επιλέξιμοι για θεραπεία με abiraterone acetate, έναν αναστολέα βιοσύνθεσης των ανδρογόνων ή με enzalutamide, έναν αναστολέα της λειτουργίας του ανδρογονικού υποδοχέα, η θεραπεία με τον αγωνιστή GnRH πρέπει να συνεχιστεί. *Ασθενείς με επηρεασμένη νεφρική ή ηπατική δυσλειτουργία:* Δεν απαιτείται προσαρμογή της δοσολογίας για ασθενείς με νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια. *Παιδιατρικός πληθυσμός:* **Πρώιμη ήβη (πριν από την ηλικία των 8 ετών στα κορίτσια και των 10 ετών στα αγόρια).** Η θεραπεία παιδιών με το Arvekap 22,5 mg πρέπει να βρίσκεται κάτω από την συνολική επίβλεψη ενός παιδοενδοκρινολόγου ή παιδιάτρου ή ενδοκρινολόγου με εξειδίκευση στη θεραπεία της κεντρικής πρώιμης ήβης.Η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί όταν πλησιάζει η φυσιολογική ηλικία της ήβης στα αγόρια και τα κορίτσια και δεν θα πρέπει να συνεχίζεται σε κορίτσια με οστική ηλικία μεγαλύτερη των 12-13 ετών. Υπάρχουν περιορισμένα διαθέσιμα δεδομένα σε αγόρια σχετικά με τον άριστο χρόνο διακοπής της αγωγής βάσει της οστικής ηλικίας, ωστόσο προτείνεται η διακοπή της αγωγής σε αγόρια με οστική ηλικία 13-14 ετών. Τρόπος χορήγησης: Το σημείο της ένεσης θα πρέπει να εναλλάσσεται περιοδικά, όπως συμβαίνει και με άλλα ενέσιμα φαρμακευτικά προϊόντα. Μετά την ανασύσταση, το εναιώρημα του Arvekap 22,5 mg πρέπει να ενίεται σχετικά γρήγορα και με χωρίς διακοπή τρόπο, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή απόφραξη της βελόνας. *Προφυλάξεις που πρέπει να ληφθούν πριν από το χειρισμό ή την χορήγηση του φαρμακευτικού προϊόντος.* Το Arvekap 22,5 mg προορίζεται αποκλειστικά για ενδομυϊκή χορήγηση. Καθώς το Arvekap 22,5 mg είναι εναιώρημα μικροσφαιριδίων, ακούσια ενδοαγγειακή ένεση πρέπει αυστηρά να αποφεύγεται. Το Arvekap 22,5 mg πρέπει να χορηγείται υπό την επίβλεψη ιατρού. Για οδηγίες σχετικά με την ανασύσταση του φαρμακευτικού προϊόντος πριν από τη χορήγηση, βλέπε παράγραφο 6.6. **4.3. Αντενδείξεις:** Υπερευαισθησία στην GnRH (εκλυτική ορμόνη των γοναδοτροπινών), τα ανάλογά της ή σε οποιοδήποτε από τα έκδοχα του φαρμακευτικού προϊόντος που αναγράφονται στην παράγραφο 6.1 (ανατρέξτε επίσης στην παράγραφο 4.8). *Η τριπτορελίνη αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας (βλ. παράγραφο 4.6).* **4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Η χρήση των GnRH αγωνιστών μπορεί να προκαλέσει μείωση της οστικής πυκνότητας. Στους άνδρες, προκαταρκτικά στοιχεία δείχνουν ότι η χρήση ενός διφωσφονικού σε συνδυασμό με έναν αγωνιστή GnRH μπορεί να μειώσει την απώλεια οστικής μάζας. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε ασθενείς με επιπρόσθετους παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση (π.χ. χρόνια κατάχρηση αλκοόλ, καπνιστές, μακροχρόνια θεραπεία με φάρμακα που μειώνουν την οστική πυκνότητα, π.χ. αντιεπιληπτικά ή κορτικοειδή, οικογενειακό ιστορικό οστεοπόρωσης, υποοιτισμός). Σε σπάνιες περιπτώσεις, η θεραπεία με αγωνιστές GnRH μπορεί να αποκαλύψει την παρουσία προηγουμένως αδιάγνωστου αδενώματος γοναδοτρόπων κυττάρων της υπόφυσης. Αυτοί οι ασθενείς μπορεί να παρουσιάσουν αποπληξία της υπόφυσης η οποία χαρακτηρίζεται από αιφνίδια κεφαλαλγία, έμετο, διαταραχές της όρασης και οφθαλμοπληγία. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος εμφάνισης κατάθλιψης (η οποία μπορεί να είναι σοβαρή) σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με GnRH ανάλογα, όπως η τριπτορελίνη. Εάν εμφανιστούν συμπτώματα οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται δεόντως και να αντιμετωπίζονται κατάλληλα. Οι ασθενείς με γνωστή κατάθλιψη πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Απαιτείται προσοχή με την ενδομυϊκή ένεση σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν αγωγή με αντιπηκτικά, λόγω πιθανού κινδύνου αιματωμάτων στο σημείο της ένεσης. Η αποτελεματικότητα και η ασφάλεια του Arvekap 22.5 mg έχει τεκμηριωθεί μόνο μέσω της ενδομυϊκής οδού χορήγησης. Η υποδόρια χορήγηση δεν συνιστάται. Αυτό το φάρμακο περιέχει λιγότερο από 1 mmol (23mg) νατρίου ανά δόση, δηλαδή είναι ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου». Καρκίνος του προστάτη: Αρχικά, η τριπτορελίνη, όπως και άλλοι αγωνιστές GnRH, προκαλεί μια παροδική αύξηση των επιπέδων της τεστοστερόνης στον ορό. Ως συνέπεια, κατά τις πρώτες εβδομάδες της θεραπείας, μπορεί να εμφανιστούν περιστασιακά μεμονωμένες περιπτώσεις παροδικής επιδείνωσης των συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη. Κατά την αρχική φάση της θεραπείας, πρέπει να εξεταστεί η πρόσθετη χορήγηση ενός κατάλληλου αντι-ανδρογόνου, ώστε να αντιπροσωπεύτει η αρχική αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης στον ορό και η επιδείνωση των κλινικών συμπτωμάτων. Μικρός αριθμός ασθενών μπορεί να εμφανίσει παροδική επιδείνωση των σημείων και συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη (έξαρση του όγκου) και παροδική αύξηση του πόνου που σχετίζεται με τον καρκίνο (μεταστατικός πόνος), ο οποίος μπορεί να αντιμετωπιστεί συμπτωματικά. Όπως και με άλλους αγωνιστές GnRH, έχουν παρατηρηθεί μεμονωμένες περιπτώσεις συμπίεσης του νωτιαίου μυελού ή απόφραξης της ουρήθρας. Αν εμφανιστεί συμπίεση νωτιαίου μυελού ή έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας, πρέπει να χορηγηθεί η συνήθης θεραπεία για αυτές τις επιπλοκές και σε ακραίες περιπτώσεις να εξεταστεί η περίπτωση άμεσης ορχεκτομής (χειρουργικού ευνουχισμού). Κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων θεραπείας ενδείκνυται προσεκτική παρακολούθηση, ιδιαίτερα σε ασθενείς με οπονδυλικές μεταστάσεις με κίνδυνο συμπίεσης του νωτιαίου μυελού και σε ασθενείς με απόφραξη των ουροφόρων οδών. Μετά από χειρουργικό ευνουχισμό, η τριπτορελίνη δεν επάγει περαιτέρω μείωση των επιπέδων της τεστοστερόνης στον ορό. Όταν επιτευχθούν επίπεδα ευνουχισμού για την τεστοστερόνη έως το τέλος του πρώτου μήνα, τα επίπεδα τεστοστερόνης στον ορό διατηρούνται για όσο διάστημα οι ασθενείς λαμβάνουν την ένεσή τους κάθε 6 μήνες (είκοσι τέσσερις εβδομάδες). Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας μπορεί να παρακολουθείται με τη μέτρηση των επιπέδων της τεστοστερόνης στον ορό και του ειδικού προστατικού αντιγόνου. Η μακρόχρονη στέρηση ανδρογόνων είτε λόγω αμφίπλευρης ορχεκτομής ή λόγω χορήγησης αναλόγων GnRH σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο απώλειας οστικής μάζας και μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση και αυξημένο κίνδυνο οστικού κατάγματος. Η θεραπεία στέρησης ανδρογόνων μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT. Σε ασθενείς με ιστορικό ή με παράγοντες κινδύνου για παράταση του διαστήματος QT και σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν ταυτόχρονη θεραπεία με φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία μπορεί να παρατείνουν το διάστημα QT (βλ. παράγραφο 4.5) οι γιατροί πρέπει να εξετάσουν το προφίλ οφέλους/κινδύνου περιλαμβανομένης της δυνατότητας για κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ρυτιδίου (Torsades de pointes) πριν την έναρξη της θεραπείας με Arvekap 22,5mg. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί από επιδημιολογικά δεδομένα ότι ασθενείς κατά τη διάρκεια θεραπείας με στέρηση ανδρογόνων μπορεί να εμφανίσουν αλλαγές στο μεταβολισμό (π.χ. δυσανεξία στη γλυκόζη) ή αυξημένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων. Παρόλα αυτά, προοπτικά στοιχεία δεν επιβεβαιώνουν τη σχέση ανάμεσα στη θεραπεία με ανάλογα GnRH και την αύξηση της θνησιμότητας λόγω καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ασθενείς με υψηλό κίνδυνο μεταβολικών ή καρδιαγγειακών παθήσεων πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά πριν την έναρξη της θεραπείας και να παρακολουθούνται επαρκώς κατά τη διάρκεια θεραπείας στέρησης ανδρογόνων. Η χορήγηση τριπτορελίνης σε θεραπευτικές δόσεις έχει ως αποτέλεσμα την κατιστολή του υποφυσιακού γοναδιακού άξονα. Η φυσιολογική λειτουργία συνήθως αποκαθίσταται με τη διακοπή της θεραπείας. Επομένως, διαγνωστικοί έλεγχοι της υποφυσιακής γοναδιακής λειτουργίας οι οποίοι διεξάγονται κατά τη διάρκεια ή και μετά τη διακοπή της θεραπείας με ανάλογα GnRH μπορεί να είναι παραπλανητικοί. Πρώιμη ήβη: Η θεραπεία παιδιών με εξελισσόμενους εγκεφαλικούς όγκους θα πρέπει να ακολουθεί μία προσεκτική ατομική εκτίμηση των κινδύνων και των οφελών. Ψευδο-πρώιμη ήβη (όγκος γονάδων ή επινεφριδίων ή υπερπλασία επινεφριδίων) και πρώιμη ήβη που δεν εξαρτάται από γοναδοτροφίνες (τεστοτοξίκωση, οικογενειακή υπερπλασία των κυττάρων Leydig) θα πρέπει να αποκλείεται. Στα κορίτσια, η αρχική διέγερση των ωοθηκών κατά την έναρξη της θεραπείας, ακολουθούμενη από την απόσυρση των ωστρογόνων την οποία επάγει η θεραπεία, μπορεί κατά τον πρώτο μήνα να οδηγήσει σε κολπική αιμορραγία ήπιας ή μέτριας έντασης. Η θεραπεία είναι μια μακροχρόνια αγωγή, η οποία ρυθμίζεται ατομικά. Το Arvekap 22.5mg πρέπει να χορηγείται όσο το δυνατόν ακριβέστερα σε τακτικές 6 μηνιαίες περιόδους. Μια κατ' εξαίρεση καθυστέρηση της ημερομηνίας ένεσης για λίγες ημέρες (169 ± 3 ημέρες) δεν επηρεάζει τα αποτελέσματα της θεραπείας. Μετά τη διακοπή της θεραπείας θα εμφανιστεί ανάπτυξη των χαρακτηριστικών της εφηβείας. Οι πληροφορίες όσον αφορά την μελλοντική γονιμότητα εξακολουθούν να είναι περιορισμένες αλλά η μελλοντική αναπαραγωγική λειτουργία και η γονιμότητα φαίνεται να μην επηρεάζονται από τη θεραπεία με GnRH.. Στα περισσότερα κορίτσια, η τακτική έμμηνος ρήση θα ξεκινήσει κατά μέσο όρο ένα χρόνο μετά τον τερματισμό της θεραπείας. Η οστική πυκνότητα (BMD) μπορεί να μειωθεί κατά τη θεραπεία της κεντρικής πρώιμης ήβης με GnRH. Ωστόσο, μετά τη διακοπή της θεραπείας, η επακόλουθη αύξηση της οστικής μάζας διατηρείται και η μέγιστη οστική μάζα στα τέλη της εφηβείας δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τη θεραπεία. Μπορεί να παρατηρηθεί επιφυσιαλίσθηση μετά την απόσυρση της θεραπείας με GnRH. Η προτεινόμενη θεωρία είναι ότι οι χαμηλές συγκεντρώσεις οιστρογόνων κατά τη διάρκεια της θεραπείας με αγωνιστές GnRH εξασθενούν την επιφυσιακή πλάκα. Η αύξηση της ταχύτητας ανάπτυξης μετά τη διακοπή της θεραπείας οδηγεί στη συνέχεια σε μείωση της δύναμης διάτμησης που απαιτείται για τη μετατόπιση της επίφυσης. **4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:** Θα πρέπει να δίδεται προσοχή όταν η τριπτορελίνη συγχορηγείται με φάρμακα τα οποία επηρεάζουν την υποφυσιακή έκκριση των γοναδοτροφινών και συνιστάται να επιβλέπεται η ορμονική κατάσταση του ασθενούς. Επειδή η θεραπεία στέρησης ανδρογόνων μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT, θα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά η ταυτόχρονη χρήση του Arvekap 22,5mg με φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία είναι γνωστό ότι παρατείνουν το διάστημα QT ή φάρμακα που μπορούν να προκαλέσουν κοιλιακή ταχυκαρδία δίκην ρυτιδίου (Torsades de pointes) όπως αντιαρρυθμικά φάρμακα τάξης IA (π.χ. κινιδίνη, δισοπυραμίδη) ή τάξης III (π.χ. αμιοδαρόνη, σοταλόλη, δοφετιλίδη, ιμπουτιλίδη), μεθαδόνη, μοξιφλοξασίνη, αντιψυχωτικά, κλπ (βλ. παράγραφο 4.4). Παιδιατρικός πληθυσμός: Μελέτες αλληλεπιδράσεων έχουν πραγματοποιηθεί μόνο σε ενήλικες. **4.6 Γονιμότητα, Κύηση και Γαλουχία:** Κύηση: Η χρήση του Arvekap 22,5 mg ενδείκνυται σε ενήλικους άνδρες και σε παιδιά. Υπάρχουν πολύ περιορισμένα δεδομένα για τη χρήση της τριπτορελίνης σε εγκύους γυναίκες. Η χρήση του Arvekap 22,5 mg δεν ενδείκνυται σε γυναίκες. Πριν από τη συνταγογράφηση Arvekap 22,5 mg, θα πρέπει να επιβεβαιωθεί ότι η ασθενής δεν είναι έγκυος. Η τριπτορελίνη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά την κύηση καθώς η ταυτόχρονη χρήση των GnRH αγωνιστών συνδέεται με ένα θεωρητικό κίνδυνο αποβολής ή εμβρυϊκής ανωμαλίας. Πριν από τη θεραπεία, δυνητικά γόνιμες γυναίκες θα πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά για να αποκλείεται η εγκυμοσύνη. Μέθοδοι μη ορμονικής αντισύλληψης πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της θεραπείας μέχρι να επιστρέψει η εμμηνορρυσία. Μελέτες σε ζώα έχουν δείξει επιδράσεις σε αναπαραγωγικές παραμέτρους (βλ.παράγραφο 5.3 Προκλινικά στοιχεία ασφαλείας). Γαλουχία: Το Arvekap 22,5 mg είναι δεν ενδείκνυται σε θηλάζουσες γυναίκες. **4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων:** Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες ως προς τις επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. Η ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων μπορεί να επηρεαστεί εάν ο ασθενής ασθενεί ζάλη, υπνηλία και οπτικές διαταραχές, οι οποίες αποτελούν πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας ή απορρέουν από την υποκείμενη νόσο. **4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Γενικά ανοχή σε άνδρες: Καθώς οι ασθενείς με τοπικά προχωρημένο ή μεταστατικό, ορμονοεξαρτώμενο καρκίνο του προστάτη είναι γενικά ηλικιωμένοι και εμφανίζουν και άλλες παθήσεις, οι οποίες είναι συχνές στον πληθυσμό αυτής της ηλικίας, περισσότερο από το 90% των ασθενών οι οποίοι συμμετείχαν σε κλινικές μελέτες ανέφεραν ανεπιθύμητες ενέργειες και επομένως συχνά είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η αιτιότητα. Όπως έχει παρατηρηθεί με άλλες θεραπείες με αγωνιστές GnRH ή μετά από χειρουργική ευνουχισμό, οι συχνότερα παρατηρούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες σχετικές με τη θεραπεία με τριπτορελίνη οφείλονταν στις αναμενόμενες φαρμακολογικές της επιδράσεις. Αυτές οι επιδράσεις περιλάμβαναν εξάψεις, στυτική δυσλειτουργία και μειωμένη γενετήσια επιθυμία. Με την εξαίρεση ανοσο-αλλεργικών αντιδράσεων (σπάνιες) και αντιδράσεων στο σημείο της ένεσης (< 5%), όλες οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι γνωστό ότι σχετίζονται με τις αλλαγές στα επίπεδα τεστοστερόνης. Αναφέρθηκαν οι ακόλουθες ανεπιθύμητες αντιδράσεις οι οποίες θεωρούνται τουλάχιστον πιθανώς σχετιζόμενες με τη θεραπεία με τριπτορελίνη. Οι περισσότερες από αυτές τις αντιδράσεις είναι γνωστό ότι σχετίζονται με βιοχημικό ή χειρουργικό ευνουχισμό. Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ταξινομείται ως εξής: *Πολύ συχνές (≥ 1/10), Συχνές (≥ 1/100, <1/10), Όχι συχνές (≥1/1000, <1/100), Σπάνιες (≥1/10000, <1/1000), Μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).*

Κατηγορία Οργανικού Συστήματος	Πολύ Συχνές	Συχνές	Όχι Συχνές	Σπάνιες	Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος Μη γνωστής συχνότητας
Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος			Θρομβοκυττάρωση		
Καρδιακές διαταραχές			Αίσθημα παλμών		Παράταση διαστήματος QT* (βλ. παραγράφους 4.4 και 4.5)
Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου			Εμβοή Ίλιγγος		
Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος					Αποπληξία της υπόφυσης.**
Οφθαλμικές διαταραχές			Επηρεασμένη όραση	Μη φυσιολογική αίσθηση οφθαλμών, Διαταραχές όρασης	
Διαταραχές του γαστρεντερικού		Ξηροστομία, Ναυτία	Κοιλιακό άλγος, Δυσκοιλιότητα, Διάρροια, Έμετος	Δύσπεψη κοιλίας, Αλλοίωση γεύσης, Μετεωρισμός	
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	Εξασθένηση	Αντίδραση στο σημείο της ένεσης (περιλαμβάνονται ερύθημα, φλεγμονή και Πόνος), Οίδημα	Λήθαργος, Περιφερικό οίδημα, Πόνος, Ρίγη, Υπνηλία	Πόνος στο στήθος, Διαταραχές στάσεως, Τριπτώδης συνδρομή, Πυρεξία	Κακουχία
Διαταραχές του ανοσοσυστήματος		Υπερευαισθησία		Αναφυλακτική αντίδραση	Αναφυλακτικό σοκ
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις				Ρινοφαρυγγίτιδα	
Παρακλινικές εξετάσεις		Αύξηση βάρους	Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξημένη, Ασπαρτική αμινοτρανσφεράση αυξημένη, Κρεατινίνη αίματος αυξημένη, Αρτηριακή πίεση αυξημένη, Ουρία αίματος αυξημένη, Γάμμα-γλουτα-μυλ-τρανσφεράση, αυξημένη, Βάρος μειωμένο	Αλκαλική φωσφατάση αίματος αυξημένη	
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης			Ανορεξία, Σακχαρώδης διαβήτης, Ουρική αρθρίτιδα, Υπερλιπιδαιμία, Αυξημένη όρεξη		
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	Οσφαλγία	Μυοσκελετικός πόνος, Πόνος στα άκρα	Αρθραλγία, Οστικός πόνος, Μυϊκή κράμπα, Μυϊκή αδυναμία, Μυαλγία	Δυσκαμψία αρθρώσεων, Διόγκωση αρθρώσεων, Μυοσκελετική δυσκαμψία, Οστεοαρθρίτιδα	
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	Παραισθησία κάτω άκρων	Ζάλη, Κεφαλαλγία	Παραισθησία	Επηρεασμένη μνήμη	
Ψυχιατρικές διαταραχές	Γενετήσια επιθυμία μειωμένη	Απώλεια γενετήσιας επιθυμίας, Κατάθλιψη*, Αλλαγές της διάθεσης*	Αϋπνία, Ευερεθιστότητα	Συγχυτική, Κατάσταση, Μειωμένη δραστηριότητα, Ευφορική διάθεση	Άγχος
Διαταραχές των νεφρών και των ουροφόρων οδών			Νυκτουρία, Κατακράτηση ούρων		Ακράτεια ούρων
Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού	Στυτική δυσλειτουργία (περιλαμβάνονται αποτυχία εκσπερμάτισης, διαταραχή εκσπερμάτισης)	Πυελικός πόνος	Γυναικομαστία, Πόνος στον μαστό, Ατροφία όρχεων, Πόνος στους όρχεις		
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου			Δύσπνοια, Επίσταξη	Ορθόπνοια	
Διαταραχές του δέρματος και του υποδορίου ιστού	Υπεριδρωσία		Ακμή, Αλωπεκία, Ερύθημα, Κνησμός, Εξάνθημα, Κνίδωση	Φυσαλίδα Πορφύρα	Αγγειονευρωτικό οίδημα

Αγγειακές διαταραχές	Εξάψεις	Υπέρταση		Υπόταση	

*Αυτή η συχνότητα βασίζεται σε συχνότητες της κατηγορίας αυτής των φαρμάκων (class-effect), κοινές για όλους τους GnRH αγωνιστές
**Αναφέρθηκε μετά την αρχική χορήγηση σε ασθενείς με αδένωμα της υπόφυσης

Η τριπτορελίνη, μέσα στην πρώτη εβδομάδα μετά την αρχική έναση της μορφής παρατεταμένης αποδέσμευσης, προκαλεί παροδική αύξηση των επιπέδων της τεστοστερόνης στην κυκλοφορία. Με αυτή την αρχική αύξηση των επιπέδων τεστοστερόνης στην κυκλοφορία, ένα μικρό ποσοστό ασθενών (≤ 5%) μπορεί να εμφανίσει προσωρινή επιδείνωση των συμπτωμάτων του καρκίνου του προστάτη (έξαρση του όγκου), η οποία συνήθως εκδηλώνεται με αύξηση των συμπτωμάτων στο ουροποιητικό (< 2%) και του μεταστατικού πόνου (5%), τα οποία μπορούν να αντιμετωπιστούν συμπτωματικά. Αυτά τα συμπτώματα είναι παροδικά και συνήθως εξαφανίζονται σε μία έως δύο εβδομάδες. Έχουν προκύψει μεμονωμένες περιπτώσεις όξυνσης συμπτωμάτων της ασθένειας, είτε απόφραξη ουρήθρας ή συμπίεση νωτιαίου μυελού λόγω μετάστασης. Επομένως, ασθενείς με μεταστατικές σπονδυλικές βλάβες και/ ή απόφραξη των άνω ή κάτω ουροφόρων οδών θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά κατά τη διάρκεια των πρώτων εβδομάδων της θεραπείας (βλέπε παράγραφο 4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Η χρήση GnRH αγωνιστών στη θεραπεία του καρκίνου του προστάτη μπορεί να σχετίζεται με αυξημένη απώλεια οστικής μάζας και μπορεί να οδηγήσει σε οστεοπόρωση και να αυξήσει τον κίνδυνο οστικού κατάγματος. Αυτό επίσης μπορεί οδηγήσει σε λανθασμένη διάγνωση οστικών μεταστάσεων. Οι ασθενείς που λαμβάνουν μακροχρόνια θεραπεία με ανάλογο GnRH σε συνδυασμό με ακτινοθεραπεία μπορεί να έχουν περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, κυρίως γαστρεντερικές και σχετιζόμενες με την ακτινοθεραπεία.

Γενική αναγή σε παιδιά (βλ. παράγραφο 4.4): Η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ταξινομείται ως εξής: *Πολύ συχνές (≥ 1/10), Συχνές (≥ 1/100 , <1/10), Όχι συχνές (≥1/1000, <1/100).*

Κατηγορία Οργανικού Συστήματος	Πολύ Συχνές	Συχνές	Όχι συχνές	Επιπλέον μετά την κυκλοφορία του προϊόντος Μη γνωστής συχνότητας
Οφθαλμικές διαταραχές			Επηρεασμένη όραση	Διαταραχές όρασης
Διαταραχές του γαστρεντερικού		Κοιλιακό άλγος	Έμετος Δυσκοιλιότητα Ναυτία	
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης		Αντίδραση στο σημείο της έωσης (περιλαμβάνονται πόνος, οίδημα, ερύθημα και φλεγμονή)	Κακουχία	
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος		Αντίδραση υπερευαισθησίας		Αναφυλακτικό σοκ
Παρακλινικές εξετάσεις		Βάρος αυξημένο		Αρτηριακή πίεση αυξημένη Προλακτίνη αίματος αυξημένη
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης			Παχυσαρκία	
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού			Πόνος στον αυχένα	Μυαλγία
Διαταραχές του νευρικού συστήματος		Κεφαλαλγία		
Ψυχιατρικές διαταραχές			Μεταβολή διάθεσης	Ευμετατλητότητα συναισθήματος Κατάθλιψη Νευρικότητα
Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού	Αιμορραγία από τον κόλπο (περιλαμβάνονται Κολπική αιμορραγία, Αιμορραγία από απόσυρση, Αιμορραγία μήτρας, Κολπική έκκριση, Κολπική αιμορραγία περιλαμβανομένης της σταγονοειδούς αιμορραγίας)		Πόνος μαστών	
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου			Επίσταξη	
Διαταραχές του δέρματος και του υποδορίου ιστού		Ακμή	Κνησμός, Εξάνθημα, Κνίδωση	Αγγειοευρωτικό οίδημα
Αγγειακές διαταραχές		Εξάψεις		Υπέρταση

Γενικά: Έχουν αναφερθεί αυξημένες τιμές λευκοκυττάρων σε ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία με ανάλογα GnRH. Αυτή η δευτερογενής λευκοκύττωση σχετίζεται προφανώς με τον ευνουχισμό που επάγεται από την GnRH και φαίνεται να υποδηλώνει ότι οι γοναδικές ορμόνες εμπλέκονται σε υποστροφή του θύμου αδένα. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: **Ελλάδα:** Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. **4.9 Υπερδοσολογία:** Οι φαρμακευτικές ιδιότητες του Arvekap 22,5 mg και του τρόπου χορήγησής του καθιστούν απίθανη την ακούσια ή εκούσια υπερδοσολογία. Δεν υπάρχει εμπειρία υπερδοσολογίας από κλινικές μελέτες. Δοκιμές σε ζώα υποδηλώνουν ότι με υψηλότερες δόσεις του Arvekap 22,5 mg, δεν είναι εμφανής καμία επίδραση στη συγκέντρωση των φυλετικών ορμονών και στην αναπαραγωγική οδό, πέραν των αναμενόμενων θεραπευτικών. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας ενδείκνυται συμπτωματική αντιμετώπιση. **5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες:** Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Ορμόνες και σχετικοί παράγοντες, ανάλογα της εκλυτικής ορμόνης κωδικός ATC: L02AE04. *Μηχανισμός δράσης και φαρμακοδυναμικές επιδράσεις:* Η τριπτορελίνη, ένας αγωνιστής GnRH, όταν χορηγείται συνεχώς και σε θεραπευτικές δόσεις, δρα ως ισχυρός αναστολέας έκκρισης των γοναδοτροπινών. Μελέτες σε ζώα και ανθρώπους δείχνουν ότι μετά τη χορήγηση τριπτορελίνης επέρχεται μία αρχική και παροδική αύξηση των κυκλοφορούντων επιπέδων της ωχρινοτρόπου ορμόνης (LH), της ωοθυλακιοτρόπου ορμόνης (FSH), της τεστοστερόνης σε άρρενες και της οιστραδιόλης σε θήλεις. Ωστόσο, χρόνια και συνεχής χορήγηση τριπτορελίνης έχει ως αποτέλεσμα τη μειωμένη έκκριση LH και FSH και την κατάσταλτή της στεροειδογένεσης στους όρχεις και τις ωοθήκες. Σε άνδρες με καρκίνο του προστάτη: Μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης στον ορό, σε επίπεδα που συνήθως απαντώνται σε χειρουργικά ευνουχισμένους άνδρες, συμβαίνει σε περίπου δύο έως τέσσερις εβδομάδες μετά την έναρξη της θεραπείας. Το Arvekap 22,5 mg έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποδεσμεύει 22,5 mg τριπτορελίνης κατά τη διάρκεια μίας περιόδου έξι μηνών. Μόλις επιτευχθούν για την τεστοστερόνη στον ορό επίπεδα ευνουχισμού έως το τέλος του πρώτου μήνα, αυτά διατηρούνται για όσο διάστημα οι ασθενείς λαμβάνουν την έναη τους κάθε εικοσιτέσσερις εβδομάδες. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ατροφία των βοηθητικών γεννητικών οργάνων. Αυτές οι επιδράσεις είναι γενικά αντιστρεπτές με τη διακοπή της χρήσης του φαρμάκου. Η αποτελεσματικότητα της θεραπείας μπορεί να παρακολουθηθεί με τη μέτρηση των επιπέδων της τεστοστερόνης στον ορό και του ειδικού προστατικού αντιγόνου. Όπως έδειξε το πρόγραμμα κλινικών μελετών, με το Arvekap 22,5 mg υπήρξε μία μέση σχετική μείωση κατά 97% στο PSA κατά το Μήνα 6. Σε πειραματικά μοντέλα με ζώα, η χορήγηση τριπτορελίνης έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή της ανάπτυξης ορισμένων ορμονοεξαρτώμενων όγκων του προστάτη. Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε καρκίνο του προστάτη: Χορήγηση Arvekap 22,5 mg με ενδομυϊκή έναη σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του προστάτη για ένα σύνολο δύο δόσεων (δώδεκα μήνες), είχε ως αποτέλεσμα την επίτευξη επιπέδων ευνουχισμού για την τεστοστερόνη στο 97,5% των ασθενών μετά από τέσσερις εβδομάδες και τη διατήρηση των επιπέδων ευνουχισμού στο 93,0% των ασθενών από το Μήνα 2 έως το Μήνα 12 της θεραπείας. Σε ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του προστάτη, ορισμένες τυχαιοποιημένες μακροχρόνιες κλινικές δοκιμές παρέχουν στοιχεία για το όφελος της θεραπείας στέρησης των ανδρογόνων (ADT) σε συνδυασμό με την ακτινοθεραπεία (RT) σε σύγκριση με την RT μόνο (RTOG 85-31, RTOG 86-10, EORTC 22863 , D'Amico et al, JAMA, 2008). Σε μια τυχαιοποιημένη μελέτης φάσης III (EORTC 22961) στην οποία συμμετείχαν 970 ασθενείς με τοπικά προχωρημένο καρκίνο του προστάτη (κυρίως T2c-T4 με ορισμένους T1C έως T2B ασθενείς με τοπική νόσο λεμφαδένων στην ιστολογική), εκ των οποίων 483 είχαν τεθεί σε βραχυχρόνιο ανδρογονικό αποκλεισμού (6 μήνες) και 487 σε μακροχρόνια θεραπεία (3 έτη) σε συνδυασμού με ακτινοθεραπεία, μια ανάλυση μη-κατωτερότητας συνέκρινε την βραχυχρόνια και τη μακροχρόνια συγχρηγούμενη και επακόλουθη στην ακτινοθεραπεία ορμονική θεραπεία με GnRH αγωνιστές, κυρίως τριπτορελίνη (62,2%) ή goserelin (30,1%). Η συνολική διηνιμότητα στα 5 έτη για την ομάδα «βραχυπρόθεσμης ορμονοθεραπείας» και την ομάδα «μακροπρόθεσμης ορμονοθεραπείας» ήταν 19,0% και 15,2% αντίστοιχα, με σχετικό κίνδυνο 1,42 (Δ.Ε. 95, 71% = 1,79; 95,71% Δ.Ε. = [1,09; 1,85], p = 0,65 για ίση αποτελεσματικότητα και p = 0,0082 για εκ των υστέρων έλεγχο της διαφοράς μεταξύ των ομάδων θεραπείας). Η ειδικά σχετιζόμενη με τον προστάτη θνητότητα εντός 5 ετών στην ομάδα «βραχυπρόθεσμης ορμονοθεραπείας» και στην ομάδα «μακροπρόθεσμης ορμονοθεραπείας» ήταν 4,78% και 3,2% αντίστοιχα, με σχετικό κίνδυνο 1,71 (95% [1,14 έως 2,57], p = 0,002). Η συνολική ποιότητα ζωής με τη χρήση QLQ-C30 δεν διέφερε σημαντικά μεταξύ των δύο ομάδων (P = 0,37). Αποδεικτικά δεδομένα για την ένδειξη του υψηλού κινδύνου εντοπιμένου καρκίνου του προστάτη βασίζονται σε δημοσιευμένες μελέτες με ακτινοθεραπεία σε συνδυασμό με GnRH ανάλογα. Αναλύθηκαν κλινικά δεδομένα από πέντε δημοσιευμένες μελέτες (EORTC 22863, RTOG 85-31, 92-02 RTOG, RTOG 8610, και D'Amico et al., JAMA, 2008), τα οποία όλα καταδεικνύουν όφελος για το συνδυασμό των αναλόγων GnRH με την ακτινοθεραπεία. Σαφής διαφοροποίηση των αντίστοιχων πληθυσμών των μελετών για τις ενδείξεις του τοπικά προχωρημένου καρκίνου του προστάτη και του υψηλού κινδύνου εντοπισμένου καρκίνου του προστάτη δεν ήταν δυνατή στις δημοσιευμένες μελέτες. Σε ασθενείς με ανθεκτικό στον ευνουχισμό μεταστατικό καρκίνο του προστάτη, οι κλινικές μελέτες έχουν δείξει το όφελος από την προσθήκη abiraterone acetate, έναν αναστολέα βιοσύνθεσης ανδρογόνων, ή enzalutamide, έναν αναστολέα του αδρογονικού υποδοχέα, στα GnRH ανάλογα άπως η τριπτορελίνη. **Κλινική αποτελεσματικότητα και ασφάλεια σε παιδιά με πρώιμη ήβη:** Σε μία μη συγκριτική κλινική μελέτη, σε 44 παιδιά με κεντρική πρώιμη ήβη (39 κορίτσια και 5 αγόρια) χορηγήθηκαν συνολικά δύο ενδομυϊκές εγχύσεις του Arvekap 22.5 mg για 12 μήνες (48 εβδομάδες). Η καταστολή των διεγερόμενων συγκεντρώσεων LH σε προ ερεθίσεις επίπεδα επιτεύχθηκε στο 95,5% των ασθενών τον μήνα 3 και σε 93,2% και 97,7% των ασθενών στους μήνες 6 και 12 αντίστοιχα. Η συνέπεια ήταν η υποχώρηση ή σταθεροποίηση των δευτερογενών χαρακτηριστικών του φύλου και η επιβράδυνση της επιταχυνόμενης ωρίμανσης και ανάπτυξης των οστών. Στα κορίτσια, η αρχική διέγερση των ωοθηκών κατά την έναρξη της θεραπείας, ακολουθούμενη από την επαγόμενη από τη θεραπεία απόσυρση των οιστρογόνων, μπορεί να οδηγήσει στον πρώτο μήνα, σε κολπική αιμορραγία ήπιας ή μέτριας έντασης. **5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες:** *Απορρόφηση:* Μετά από μία εφάπαξ ενδομυϊκή έωση του Arvekap 22,5 mg σε ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, ο t_{max} ήταν 3 (2–12 ώρες) και η C_{max} (0-169 ημέρες) ήταν 40,0 (22,2 – 76,8) ng/mL. *Σε παιδιά με πρώιμη ήβη η τιμαx ήταν 4 (2-8) ώρες και η Cmax (0-169 ημέρες) ήταν 39,9 (19,1 - 107,0) ng / ml* Η τριπτορελίνη δεν συσσωρεύτηκε κατά τους δύο δόσεις μήνες της θεραπείας. *Κατανομή:* Αποτελέσματα φαρμακοκινητικών μελετών που διεξήχθηκαν σε υγιείς άνδρες υποδεικνύ-ουν ότι μετά από ενδοφλέβια χορήγηση μάζας τριπτορελίνης, αυτή κατανέμεται και καταβολίζεται σύμφωνα με ένα μοντέλο τριών διαμερισμάτων, ενώ οι αντίστοιχοι χρόνοι ημίζωής είναι περίπου 6 λεπτά, 45 λεπτά και 3 ώρες. Ο όγκος κατανομής της τριπτορελίνης σε σταθερή κατάσταση μετά από ενδοφλέβια χορήγηση 0,5 mg triptorelin acetate σε υγιείς άρρενες εθελοντές είναι περίπου 30 L. Εφόσον δεν υπάρχουν στοιχεία ότι η τριπτορελίνη διεφεύγεται στις πρωτεΐνες του πλάσματος σε κλινικά σημαντικές συγκεντρώσεις, είναι απίθανες οι αλληλεπιδράσεις φαρμακευτικών προϊόντων οι οποίες οφείλονται σε εκτόπιση από θέσεις πρόσδεσης. *Βιομετασχηματισμός:* Μεταβολίτες της τριπτορελίνης δεν έχουν προσδιοριστεί σε ανθρώπους. Ωστόσο, ανθρώπινα φαρμακοκινητικά δεδομένα υποδηλώνουν ότι θραύσματα από το C-άκρο παραγόμενα μετά από αποικοδόμηση σε ιστούς, είτε διασπώνται τελείως μέσα στους ιστούς, είτε αποικοδομούνται περαιτέρω στο πλάσμα ή εκκαθαρίζονται από τα νεφρά. *Αποβολή:* Η τριπτορελίνη καταβολίζεται στο ήπαρ και στα νεφρά. Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση 0,5 mg τριπτορελίνης σε υγιείς άρρενες εθελοντές, το 42% της δόσης απεκκρίθηκε στα ούρα ως ανέπαφη τριπτορελίνη, ενώ αυξήθηκε στο 62% σε ασθενείς με έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας. Εφόσον η κάθαρση κρεατινίνης (Cl_{creat}) σε υγιείς εθελοντές ήταν 150 mL/min και μόνο 90 mL/min σε ασθενείς με έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας, αυτό υποδεικνύει ότι το ήπαρ είναι σημαντικό σημείο καταβολισμού της τριπτορελίνης. Σε αυτούς τους υγιείς εθελοντές ο πραγματικός τελικός χρόνος ημίζωής της τριπτορελίνης ήταν 2,8 ώρες και η ολική κάθαρση της τριπτορελίνης ήταν 212 mL/min, με αυτή να εξαρτάται από ένα συνδυασμό ηπατικής και νεφρικής κάθαρσης. *Άλλοι Ειδικοί πληθυσμοί:* Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση 0,5 mg τριπτορελίνηςσε ασθενείς με μέτρια νεφρική ανεπάρκεια (Cl_{creat} 40 mL/min) η τριπτορελίνη εμφάνισε χρόνο ημίζωής αποβολής 6,7 ώρες, σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια (Cl_{creat} 8,9 mL/min) 7,81 ώρες και σε ασθενείς με έκπτωση της ηπατικής λειτουργίας (Cl_{creat} 89,9 mL/min) 7,65 ώρες. Δεν έχουν μελετηθεί συστηματικά οι επιδράσεις της ηλικίας και της φυλής στην φαρμακοκινητική της τριπτορελίνης. Ωστόσο, φαρμακοκινητικά στοιχεία που προέκυψαν από νέους υγιείς άρρενες εθελοντές ηλικίας 20 έως 22 ετών, με αυξημένη κάθαρση κρεατινίνης (περίπου 150 mL/min), έδειξαν ότι η τριπτορελίνη απομακρύνθηκε δύο φορές ταχύτερα στο νεανικό πληθυσμό. Αυτό συνδέεται με το γεγονός ότι η κάθαρση της τριπτορελίνης συσχετίζεται με την ολική κάθαρση κρεατινίνης, η οποία είναι γνωστό ότι ελαττώνεται με την ηλικία. Λόγω του μεγάλου περιθωρίου ασφάλειας της τριπτορελίνης και καθώς το Arvekap 22,5 mg είναι μορφή παρατεταμένης αποδέσμευσης, δεν συνιστάται προσαρμογή της δόσης σε ασθενείς με έκπτωση της νεφρικής ή ηπατικής λειτουργίας. *Φαρμακοκινητικές / φαρμακοδυναμικές σχέσεις:* Δεν μπορεί να αξιολογηθεί άμεσα η σχέση φαρμακοκινητικής / φαρμακοδυναμικής της τριπτορελίνης καθώς είναι μη γραμμική και χρονοεξαρτώμενη. Μετά από οξεία χορήγηση σε εθελοντές χωρίς προηγούμενη θεραπεία, η τριπτορελίνη επάγει μία δοσοεξαρτώμενη αύξηση της απόκρισης των LH και FSH. Όταν χορηγείται σε μορφή παρατεταμένης αποδέσμευσης, η τριπτορελίνη, κατά τις πρώτες μέρες μετά τη χορήγηση, διεγείρει την έκκριση LH και FSH και κατά συνέπεια την έκκριση τεστοστερόνης. Όπως έχουν δείξει τα αποτελέσματα διαφορετικών μελετών βιοϊσοδυναμίας, η μέγιστη αύξηση της τεστοστερόνης επιτυγχάνεται μετά από περίπου τέσσερις ημέρες με μία ισοδύναμη C_{max} η οποία είναι ανεξάρτητη από το ρυθμό απελευθέρωσης της τριπτορελίνης. Η αρχική απάντηση δεν διατηρείται παρά τη συνεχή έκθεση στην τριπτορελίνης και ακολουθείται από μία προοδευτική και ισοδύναμη μείωση των επιπέδων τεστοστερόνης. Σε αυτή την περίπτωση, η έκταση της έκθεσης στην τριπτορελίνη μπορεί να ποικίλει αρκετά χωρίς να επηρεάζει τη συνολική επίδραση στα επίπεδα της τεστοστερόνης στον ορό. **5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια:** Η τοξικότητα της τριπτορελίνης σε εξωγεννητικά όργανα είναι χαμηλή. Τα αποτελέσματα που παρατηρήθηκαν σχετίζονταν κυρίως με την όξυνση των φαρμακολογικών επιδράσεων της τριπτορελίνης. Σε μελέτες χρόνιας τοξικότητας με κλινικά σχετικές δόσεις, η τριπτορελίνη επέφερε μακρο- και μικροσκοπικές αλλαγές στα αναπαραγωγικά όργανα αρσενικών αρουραίων, σκύλων και πιθήκων. Αυτές θεωρήθηκαν ως μία αντίδραση στην κατεσταλμένη λειτουργία των γονάδων η οποία προκλήθηκε από την φαρμακολογική δράση της ουσίας. Οι αλλαγές ήταν μερικώς αντιστρεπτές κατά τη διάρκεια της ανάρρωσης. Μετά από υποδόρια χορήγηση 10 μg/kg σε αρουραίους κατά τις ημέρες 6 έως 15 της κυοφορίας, η τριπτορελίνη δεν προκάλεσε καμία εμβρυοτοξική, τερατογόνο ή άλλη επίδραση στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς (γενιά F1) ή στην αναπαραγωγική της ικανότητα. Στα 100 μg/kg παρατηρήθηκε μείωση της αύξησης του σωματικού βάρους της μητέρας και αυξημένος αριθμός υποστροφών του κυήματος. Η τριπτορελίνη δεν είναι μεταλλαξογόνος *in vitro ή in vivo*. Με την τριπτορελίνη δεν έχει αποδειχθεί καμία ογκογόνος επίδραση σε ποντίκια σε δόσεις έως 6000 μg/kg μετά από 18 μήνες θεραπείας. Μία μελέτη καρκινογένεσης σε αρουραίους, η οποία διήρκεσε 23 μήνες, έδειξε αγεδόν 100% επίπτωση καλοήθων όγκων της υπόφυσης σε κάθε επίπεδο δόσης που οδήγησαν σε πρόωρο θάνατο. Η αυξημένη επίπτωση υποφυσιακών όγκων στους αρουραίους είναι συγνή επίδραση η οποία σχετίζεται με τη χορήγηση αγωνιστών GnRH. Η κλινική σημασία αυτής της επίδρασης δεν είναι γνωστή. **6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 6.1 Κατάλογος εκδόχων:** *Κόνις:* poly (d,l-lactide-co-glycolide), mannitol, carmellose sodium, polysorbate 80. *Διαλύτης:* Water for injections. **6.2 Ασυμβατότητες:** Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. **6.3 Διάρκεια ζωής:** 3 έτη. Να χρησιμοποιείται αμέσως μετά την αναδύσταση. Από μικροβιολογικής άποψης, το έτοιμο προς χρήση ενέσιμο εναιώρημα πρέπει να χρησιμοποιείται αμέσως. Αν δεν χρησιμοποιηθεί αμέσως, οι κατά τη χρήση χρόνοι και συνθήκες αποθήκευσης πριν τη χρήση είναι ευθύνη του χρήστη και κανονικά θα πρέπει να μην υπερβαίνουν τις 24 ώρες στους 2 έως 8 °C. **6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος.** Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25 °C. Για τις συνθήκες φύλαξης του αναστασθέντος φαρμακευτικού προϊόντος βλέπε παράγραφο 6.3. **6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη:** Φιαλίδιο σκόνης: 6 ml. Διάφανο ανοιχτό καφέ φιαλίδιο (γυαλί τύπου Ι) με πώμα βρωμοβουτυλίου και κατάκι αλουμινίου με σκούρο πράσινο αποσπώμενο κάλυμμα. Φύσιγγα διαλύτη: Διάφανη, άχρωμη φύσιγγα (γυαλί τύπου Ι) που περιέχει 2 ml. στείρου διαλύτη για εναιώρημα. *Καυτί με:* 1 φιαλίδιο, 1 φύσιγγα και 1 συσκευασία που περιέχει 1 σύριγγα και 2 βελόνες για την έναη. **6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός:** Το ενέσιμο εναιώρημα πρέπει να αναδυσταθεί με χρήση άσηπτης τεχνικής και μόνο χρησιμοποιώντας τη φύσιγγα διαλύτη για την έναη. Οι οδηγίες αναδύστασης που αναφέρονται κατωτέρω όπως και στο φύλλο οδηγιών πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά. Ο διαλύτης θα πρέπει να αναρροφηθεί με τη σύριγγα η οποία παρέχεται με χρήση της βελόνας για την αναδύσταση (20G, χωρίς σύστημα ασφαλείας) και να μεταφερθεί στο φιαλίδιο που περιέχει τη σκόνη. Το εναιώρημα πρέπει να αναδυσταθεί με ήπια οριζόντια ανακίνηση του φιαλιδίου ώστε να προκύψει ένα ομογενές, γαλακτώδες εναιώρημα. Μην αναστρέφετε το φιαλίδιο. Ένας σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει μη αναδυσταμένη σκόνη στο φιαλίδιο.Το προκύπτον εναιώρημα πρέπει στη συνέχεια να αναρροφηθεί μέσα στη σύριγγα χωρίς να αναστραφεί το φιαλίδιο. Κατόπιν, η βελόνα για την αναδύσταση πρέπει να αλλαχθεί και να χρησιμοποιηθεί η βελόνα για την έναη (20G, με συσκευή ασφαλείας) για να χορηγηθεί το προϊόν. Καθώς το προϊόν είναι εναιώρημα, η έναη πρέπει να χορηγείται αμέσως μετά την αναδύσταση για να αποφευχθεί καθίζηση . Για εφάπαξ χρήση. Χρησιμοποιημένες βελόνες, χρησιμοποιήτα υλικά, εναιώρημα ή άλλα άχρηστα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις. *Κάθε χρησιμοποιήτο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις.* **7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** IPSEN ΜΕΠΕ, Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 174 56, Αθήνα. **8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** 29553/5-3-2020. **9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης : 3-3-2011. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 5-3-2020. **10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 08/07/2022

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

• Τ.Π.: 425,32€
• Λ.Τ: 498,77€
• Δ.Τ.Φ.: 23/12/2021

IPSEN ΜΟΝ.ΕΠΕ
Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 ΑΛΙΜΟΣ
Τηλέφωνο: 210 98 43 324, 210 98 58 930 & 210 98 58 940, Φαξ: 210 98 87 911
E-mail: ipsenepe@ipsen.com, http://www.ipsen.gr
Τηλέφωνα φαρμακοεπαγρύπνησης: 210 98 43 324, 210 98 58 930

Innovation for patient care

10 ARV 11,25/3,75/22,5-B/ΙΟΥΛ 2022.

ERLEADA® Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Erleada 60 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. **ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:** Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 60 mg apalutamide. **ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:** Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο (δισκίο). Ελαφρώς κιτρινωπά προς γκριζοπράσινα, επιμήκη, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία (16,7 mm μήκος x 8,7 mm πλάτος), με χαραγμένη την ένδειξη «AR 60» στη μία πλευρά. **ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεραπευτικές ενδείξεις:** Το Erleada ενδείκνυται: • για τη θεραπεία του μη μεταστατικού, ανθεκτικού στον ευνουχισμό καρκίνο του προστάτη (nm-CRPC) σε ενήλικους άνδρες, οι οποίοι διατρέχουν υψηλό κίνδυνο να αναπτύξουν μεταστατική νόσο. • σε ενήλικους άνδρες για τη θεραπεία του μεταστατικού, ορμονοευαίσθητου καρκίνου του προστάτη (mHSPC) σε συνδυασμό με θεραπεία στέρησης ανδρογόνων (ADT). **Αντενδείξεις:** Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Γυναίκες που είναι ή ενδέχεται να μείνουν έγκυος. **Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:** Επιληπτικές κρίσεις: Το Erleada δεν ενδείκνυται σε ασθενείς με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή άλλων προδιαθεσικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων μεταξύ άλλων υποκείμενου εγκεφαλικού τραύματος, πρόσφατου αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (εντός ενός έτους), πρωτοπαθών όγκων εγκεφάλου ή εγκεφαλικών μεταστάσεων. Εάν παρουσιαστεί επιληπτική κρίση κατά τη διάρκεια της θεραπείας με Erleada, η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί οριστικά. Ο κίνδυνος για επιληπτικές κρίσεις ενδέχεται να είναι αυξημένος σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία μειώνουν τον ουδό των επιληπτικών κρίσεων. Σε δύο τυχαιοποιημένες μελέτες (SPARTAN και TITAN), επιληπτικές κρίσεις εμφανίστηκαν στο 0,6% των ασθενών που έλαβαν apalutamide και στο 0,2% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με εικονικό φάρμακο. Σε αυτές τις κλινικές μελέτες αποκλείστηκε η συμμετοχή ασθενών με ιστορικό επιληπτικών κρίσεων ή προδιαθεσικούς παράγοντες για επιληπτικές κρίσεις. Δεν υπάρχει κλινική εμπειρία στην εκ νέου χορήγηση Erleada σε ασθενείς που εμφάνισαν επιληπτική κρίση. Πτώσεις και κατάγματα: Πτώσεις και κατάγματα σημειώθηκαν σε ασθενείς που έλαβαν apalutamide (βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Οι ασθενείς θα πρέπει να αξιολογούνται σχετικά με τον κίνδυνο για πτώσεις και κατάγματα πριν την έναρξη του Erleada και η παρακολούθηση και η διαχείριση τους θα πρέπει να συνεχίζεται σύμφωνα με τις καθιερωμένες συστάσεις θεραπείας και θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο χρήσης παραγόντων στέγνωσης των οστών. Ισχαιμική καρδιοπάθεια και ισχαιμικές διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου: Ισχαιμική καρδιοπάθεια και ισχαιμικές διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου, συμπεριλαμβανομένων συμβάντων που οδήγησαν σε θάνατο, εμφανίστηκαν σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με apalutamide (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Η πλειοψηφία των ασθενών είχαν παράγοντες κινδύνου καρδιακής / ισχαιμικής αγγειακής εγκεφαλικής νόσου. Οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται για σημεία και συμπτώματα ισχαιμικής καρδιοπάθειας και ισχαιμικών διαταραχών των αγγείων του εγκεφάλου. Η διαχείριση παραγόντων κινδύνου, όπως η υπέρταση, ο διαβήτης ή η δυολιπιδαιμία θα πρέπει να βελτιστοποιείται, σύμφωνα με την καθιερωμένη φροντίδα. Ταυτόχρονη χρήση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα: Το apalutamide είναι ένας ισχυρός επαγωγέας ενζύμων και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της αποτελεσματικότητας πολλών φαρμακευτικών προϊόντων ευρείας χρήσεως. Συνεπώς, θα πρέπει να γίνεται επανεξέταση των συγχορηγούμενων φαρμακευτικών προϊόντων κατά την έναρξη της θεραπείας με apalutamide. Η ταυτόχρονη χρήση του apalutamide με φαρμακευτικά προϊόντα που είναι ευαίσθητα υποστρώματα πολλών μεταβολικών ενζύμων ή μεταφορέων θα πρέπει γενικά να αποφεύγεται εάν η θεραπευτική τους δράση είναι μεγάλης σημασίας για τον ασθενή και δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν εύκολα προσαρμογές της δόσης, βάσει της παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας ή των συγκεντρώσεων στο πλάσμα. Η συγχορήγηση του apalutamide με βαρφαρίνη και κουμαρινικά αντιπηκτικά θα πρέπει να αποφεύγεται. Εάν το Erleada συγχορηγείται με ένα αντιπηκτικό που μεταβολίζεται από το CYP2C9 (όπως η βαρφαρίνη ή η ασενοκουμαρόλη), θα πρέπει επιπροσθέτως να παρακολουθείται ο Διεθνής Κανονικοποιημένος Λόγος (INR). Πρόσφατη καρδιαγγειακή νόσος: Ασθενείς με κλινικά σημαντική καρδιαγγειακή νόσο κατά τους τελευταίους 6 μήνες, συμπεριλαμβανομένης της σοβαρής/αστάθούς στηθάγχης, του εμφράγματος του μυοκαρδίου, της συμπτωματικής συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας, των αρτηριακών ή φλεβικών θρομβοεμβολικών επεισοδίων (π.χ., πνευμονική εμβολή, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, συμπεριλαμβανομένων των παροδικών ισχαιμικών επεισοδίων) ή των κλινικά σημαντικών κοιλιακών αρρυθμιών αποκλείστηκαν από τις κλινικές μελέτες. Ως εκ τούτου, δεν έχει τεκμηριωθεί η ασφάλεια του apalutamide σε αυτούς τους ασθενείς. Εάν το Erleada συνταγογραφηθεί, οι ασθενείς με κλινικά σημαντική καρδιαγγειακή νόσο θα πρέπει να παρακολουθούνται για παράγοντες κινδύνου όπως υπερχοληστερολαιμία, υπερτριγλυκεριδαιμία ή άλλες καρδιομεταβολικές διαταραχές (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Οι ασθενείς θα πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία για αυτές τις καταστάσεις, εφόσον απαιτείται, μετά την έναρξη του Erleada, σύμφωνα με τις καθιερωμένες συστάσεις θεραπείας. Η θεραπεία στέρησης ανδρογόνων μπορεί να παρατείνει το διάστημα QT: Σε ασθενείς με ιστορικό ή παράγοντες κινδύνου για παράταση του διαστήματος QT, καθώς και σε ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία ενδέχεται να παρατείνουν το διάστημα QT, οι ιατροί θα πρέπει να αξιολογούν την αναλογία οφέλους-κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας εμφάνισης κοιλιακής ταχυκαρδίας δίκην ριπιδίου (Torsade de pointes) πριν την έναρξη του Erleada. Σύνδρομο Stevens-Johnson (SJS)/τοξική επιδερμική νεκρόλυση (TEN): Αναφορές SJS/TEN μετά την κυκλοφορία, τα οποία μπορεί να είναι απειλητικά για τη ζωή ή θανατηφόρα, έχουν παρατηρηθεί σε συσχέτιση με τη θεραπεία με Erleada και η συχνότητα εμφάνισης είναι «μη γνωστές» (βλέπε παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με σημεία και συμπτώματα που υποδηλώνουν SJS/TEN. Εάν παρατηρηθούν αυτά τα συμπτώματα, το Erleada θα πρέπει να διακοπεί αμέσως και οι ασθενείς θα πρέπει να αναζητήσουν άμεση ιατρική συμβουλή. Το Erleada δεν πρέπει να ξεκινά εκ νέου σε ασθενείς που παρουσίασαν SJS/TEN οποιαδήποτε στιγμή ενόσω λάμβαναν Erleada και θα πρέπει να εξετάζεται το ενδεχόμενο εναλλακτικής θεραπείας. **Ανεπιθύμητες ενέργειες:** Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι κόπωση (26%), δερματικό εξάνθημα (26% οποιουδήποτε βαθμού και 6% Βαθμού 3 ή 4), υπέρταση (22%), έξαψη (18%), αρθραλγία (17%), διάρροια (16%), πτώση (13%) και μείωση σωματικού βάρους (13%). Άλλες σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειες περιλαμβάνουν κατάγματα (11%) και υποθυρεοειδισμό (8%). Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών παρατίθενται παρακάτω ανά κατηγορία συχνότητας εμφάνισης. Οι κατηγορίες συχνότητας εμφάνισης ορίζονται ως ακολούθως: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1 000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10 000 έως < 1/1 000), πολύ σπάνιες (< 1/10 000) και μη γνωστές (η συχνότητα εμφάνισης δεν μπορεί να εκτιμηθεί με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας.

Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες ενέργειες που διαπιστώθηκαν σε κλινικές μελέτες

Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα	Ανεπιθύμητη ενέργεια και συχνότητα εμφάνισης[α]
Διαταραχές του ενδοκρινικού συστήματος	συχνές: υποθυρεοειδισμός[β]
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης	πολύ συχνές: μειωμένη όρεξη
	συχνές: υπερχοληστερολαιμία, υπερτριγλυκεριδαιμία
Διαταραχές του νευρικού συστήματος	συχνές: δυσγευσία, ισχαιμικές διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου[γ]
	όχι συχνές: επιληπτική κρίση[δ] (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση)
Καρδιακές διαταραχές	συχνές: ισχαιμική καρδιοπάθεια[ε]
	μη γνωστές: παράταση του διαστήματος QT (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση)
Αγγειακές διαταραχές	πολύ συχνές: έξαψη, υπέρταση
Διαταραχές του γαστρεντερικού	πολύ συχνές: διάρροια
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού	πολύ συχνές: δερματικό εξάνθημα[ζ]
	συχνές: κνησμός, αλωπεκία
	μη γνωστές: σύνδρομο Stevens-Johnson/τοξική επιδερμική νεκρόλυση[η,θ]
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού	πολύ συχνές: κάταγμα[ι], αρθραλγία
	συχνές: μυϊκός σπασμός
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης	πολύ συχνές: κόπωση
Παρακλινικές εξετάσεις	πολύ συχνές: μειωμένο σωματικό βάρος
Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισμών	πολύ συχνές: πτώση

[α] Οι συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών που παρουσιάζονται βασίζονται στην ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο περίοδο των κλινικών μελετών

[β] Περιλαμβάνεται υποθυρεοειδισμός, αυξημένα επίπεδα θυρεοειδοτρόπου ορμόνης στο αίμα, μειωμένη θυροξίνη, αυτοάνοση θυρεοειδίτιδα, μειωμένη ελεύθερη θυροξίνη, μειωμένη τριιωδοθυρονίνη

[γ] Περιλαμβάνεται παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, διαταραχή των αγγείων του εγκεφάλου, ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, αρτηριοσκλήρυνση καρωτίδας, στένωση καρωτίδας, ημιπάρεση, βοθριωτό έμφρακτο, βοθριωτό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, θρομβωτικό εγκεφαλικό έμφρακτο, αγγειακή εγκεφαλοπάθεια, έμφρακτο παρεγκεφαλίδας, εγκεφαλικό έμφρακτο και εγκεφαλική ισχαιμία

[δ] Περιλαμβάνει δάγκωμα της γλώσσας

[ε] Περιλαμβάνει στηθάγχη, ασταθή στηθάγχη, έμφραγμα του μυοκαρδίου, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου, απόφραξη στεφανιαίας αρτηρίας, στένωση στεφανιαίας αρτηρίας, οξύ στεφανιαίο σύνδρομο, αρτηριοσκλήρυνση στεφανιαίας αρτηρίας, δοκιμασία κοπώσεως μη φυσιολογική, αυξημένη τροπονίνη, ισχαιμία του μυοκαρδίου

[ζ] Βλέπε «Δερματικό εξάνθημα» στην ενότητα «Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών»

[η] Ανεπιθύμητη ενέργεια μετά την κυκλοφορία

[θ] Βλέπε παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση

[ι] Περιλαμβάνεται κάταγμα πλευρών, κάταγμα οσφυϊκού σπονδύλου, συμπιεστικό κάταγμα σπονδυλικής στήλης, κάταγμα σπονδυλικής στήλης, κάταγμα άκρου ποδός, κάταγμα ισχίου, κάταγμα βραχιόνιου οστού, κάταγμα θωρακικού σπονδύλου, κάταγμα άνω άκρου, κάταγμα ιερού οστού, κάταγμα άκρας χείρας, κάταγμα ηβικού οστού, κάταγμα κοτύλης, κάταγμα αστραγάλου, συμπιεστικό κάταγμα, κάταγμα πλευρικού χόνδρου, κάταγμα οστών του προσώπου, κάταγμα κάτω άκρου, οστεοπορωτικό κάταγμα, κάταγμα καρπού, αποσπαστικό κάταγμα, κάταγμα περόνης, κάταγμα κόκκυγα, κάταγμα πυέλου, κάταγμα κερκίδας, κάταγμα στέρνου, κάταγμα από υπερβολική επιβάρυνση, μετατραυματικό κάταγμα, κάταγμα αυχενικού σπονδύλου, κάταγμα του αυχένα του μηριαίου οστού, κάταγμα κνήμης. Βλέπε παρακάτω.

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: *Δερματικό εξάνθημα:* Το δερματικό εξάνθημα που σχετίζεται με το apalutamide περιγράφηκε συνήθως ως κηλιδώδες ή κηλιδοβλατιδώδες. Στο δερματικό εξάνθημα περιλαμβάνεται εξάνθημα, κηλιδοβλατιδώδες εξάνθημα, γενικευμένο εξάνθημα, κνίδωση, κνησμώδες εξάνθημα, κηλιδώδες εξάνθημα, επιπεφυκίτιδα, πολύμορφο ερύθημα, βλατιδώδες εξάνθημα, αποφολίδωση δέρματος, εξάνθημα γεννητικών οργάνων, ερυθηματώδες εξάνθημα, στοματίτιδα, φαρμακευτικό εξάνθημα, στοματικά έλκη, φλυκταινώδες εξάνθημα, φλύκταινες, βλατίδες, πεμφιγοειδές, διάβρωση του δέρματος, δερματίτιδα και κυστικό εξάνθημα Ανεπιθύμητες ενέργειες δερματικού εξανθήματος αναφέρθηκαν στο 26% των ασθενών που έλαβαν apalutamide. Βαθμού 3 δερματικά εξανθήματα (ορίστηκαν ως εκείνα που καλύπτουν > 30% της επιφάνειας σώματος [BSA]) αναφέρθηκαν με τη θεραπεία με apalutamide στο 6% των ασθενών. Ο διάμεσος χρόνος έως την εμφάνιση δερματικού εξανθήματος ήταν 83 ημέρες. Στο 78% των ασθενών το εξάνθημα απέδραμε, με διάμεσο χρόνο έως την αποδρομή 78 ημέρες. Στα φαρμακευτικά προϊόντα που χρησιμοποιήθηκαν περιλαμβάνονταν τοπικά κορτικοστεροειδή, από στόματος αντιισταμινικά και το 19% των ασθενών έλαβαν συστηματικά κορτικοστεροειδή. Στους ασθενείς με δερματικό εξάνθημα, η δόση διεκόπη στο 28% των ασθενών και ελαττώθηκε στο 14% των ασθενών. Το δερματικό εξάνθημα επανεμφανίστηκε στο 59% των ασθενών στους οποίους πραγματοποιήθηκε προσωρινή διακοπή της δόσης. Το δερματικό εξάνθημα οδήγησε σε διακοπή της θεραπείας με apalutamide στο 7% των ασθενών που εμφάνισαν δερματικό εξάνθημα. *Πτώσεις και κατάγματα:* Στη μελέτη ARN-509-003, κάταγμα αναφέρθηκε στο 11,7% των ασθενών που έλαβαν apalutamide και στο 6,5% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Οι μισοί ασθενείς είχαν πτώση μέσα σε διάστημα 7 ημερών πριν από το κάταγμα και στις δύο ομάδες θεραπείας. Πτώσεις αναφέρθηκαν στο 15,6% των ασθενών που έλαβαν apalutamide, έναντι 9,0% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). *Ισχαιμική καρδιοπάθεια και ισχαιμικές διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου:* Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη (SPARTAN) σε ασθενείς με nmCRPC, ισχαιμική καρδιοπάθεια εμφανίστηκε στο 4% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με apalutamide και στο 3% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Σε μία τυχαιοποιημένη μελέτη (TITAN) σε ασθενείς με mHSPC, ισχαιμική καρδιοπάθεια εμφανίστηκε στο 4% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με apalutamide και στο 2% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Συνολικά, στις μελέτες SPARTAN και TITAN, 6 ασθενείς (0,5%) που έλαβαν apalutamide και 2 ασθενείς (0,2%) που έλαβαν εικονικό φάρμακο απεβίωσαν λόγω ισχαιμικής καρδιοπάθειας (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Στη μελέτη SPARTAN, με μία διάμεση έκθεση 32,9 μηνών για το apalutamide και 11,5 μηνών για το εικονικό φάρκακο, ισχαιμικές διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου εμφανίστηκαν στο 4% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με apalutamide και στο 1% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο (βλ. παραπάνω). Στη μελέτη TITAN, ισχαιμικές διαταραχές των αγγείων του εγκεφάλου εμφανίστηκαν σε παρόμοια αναλογία στους ασθενείς στις ομάδες του apalutamide (1,5%) και του εικονικού φαρμάκου (1,5%). Συνολικά, στις μελέτες SPARTAN και TITAN, 2 ασθενείς (0,2%) που έλαβαν apalutamide και κανένας από τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο απεβίωσαν λόγω ισχαιμικής διαταραχής των αγγείων του εγκεφάλου (βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). *Υποθυρεοειδισμός:* Υποθυρεοειδισμός αναφέρθηκε στο 8% των ασθενών που έλαβαν apalutamide και στο 2% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο, με βάση τις αξιολογήσεις της θυρεοειδοτρόπου ορμόνης (TSH) ανά 4 μήνες. Δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες Βαθμού 3 ή 4. Υποθυρεοειδισμός εμφανίστηκε στο 30% των ασθενών που λάμβαναν ήδη θεραπεία υποκατάστασης του θυρεοειδούς στο σκέλος του apalutamide και στο 3% των ασθενών στο σκέλος του εικονικού φαρμάκου. Στους ασθενείς που δεν λάμβαναν θεραπεία υποκατάστασης του θυρεοειδούς, υποθυρεοειδισμός εμφανίστηκε στο 7% των ασθενών που έλαβαν apalutamide και στο 2% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Όταν ενδείκνυται κλινικά, πρέπει να ξεκινά θεραπεία υποκατάστασης του θυρεοειδούς ή να προσαρμόζεται η δόση της. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 2106549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. **ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** EU/1/18/1342/001. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:** 18 Νοεμβρίου 2021. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ / ΤΙΜΕΣ

Περιεκτικότητα	Συσκευασία	Νοσοκομειακή Τιμή	Λιανική Τιμή
F.C.TAB 60MG/TAB	BTx112 δισκία σε blisters PVC/PCTFE/alu	2.415,28 €	2.918,66 €

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 8090000.